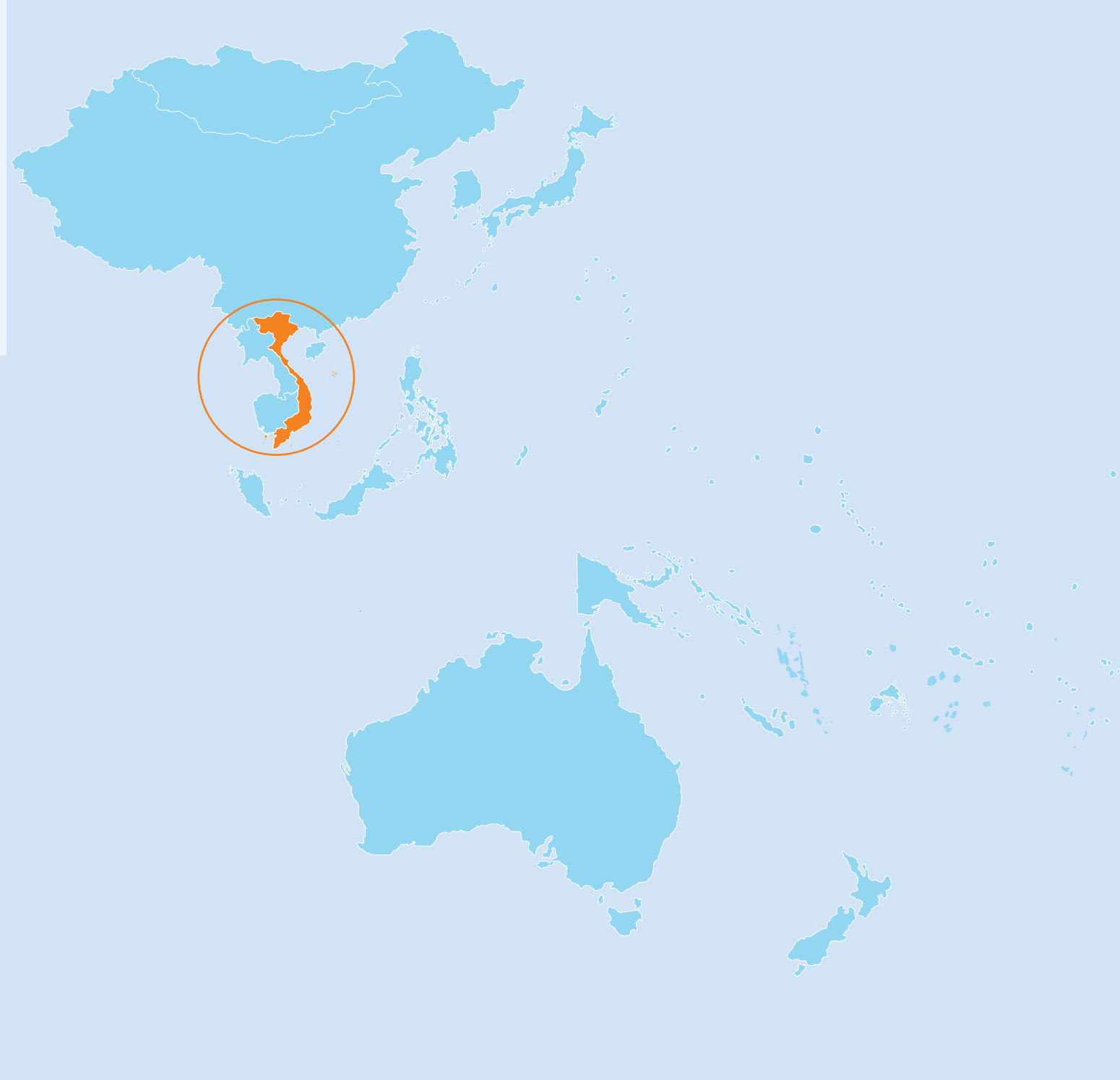




Tổng quan quốc gia về
Nhân lực y tế

Việt Nam



World Health
Organization

Western Pacific Region

Tổng quan quốc gia về Nhân lực y tế

Việt Nam

WHO Library Cataloguing-in-Publication Data

Human resources for health country profiles: Viet Nam

1. Health manpower. 2. Health personnel. 3. Health resources. 4. Vietnam.
I. World Health Organization Regional Office for the Western Pacific

ISBN 978 92 9061 834 8 (NLM Classification: **W76 JV6**)

© World Health Organization 2018

All rights reserved. Publications of the World Health Organization are available on the WHO web site (www.who.int) or can be purchased from WHO Press, World Health Organization, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland (tel.: +41 22 791 3264; fax: +41 22 791 4857; e-mail: bookorders@who.int).

Requests for permission to reproduce or translate WHO publications—whether for sale or for non-commercial distribution—should be addressed to WHO Press through the WHO web site (www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html). For WHO Western Pacific regional publications, request for permission to reproduce should be addressed to Publications Office, World Health Organization, Regional Office for the Western Pacific, P.O. Box 2932, 1000, Manila, Philippines, fax: +632 521 1036, e-mail: publications@wpro.who.int. The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

The mention of specific companies or of certain manufacturers' products does not imply that they are endorsed or recommended by the World Health Organization in preference to others of a similar nature that are not mentioned. Errors and omissions excepted, the names of proprietary products are distinguished by initial capital letters.

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this publication. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

Mục lục

Mục lục	5
Danh mục các bảng	6
Danh mục các hình	7
Lời cảm ơn	8
Danh mục chữ viết tắt	10
Tóm tắt báo cáo	11
1 Giới thiệu	14
1.1 Thông tin về nhân khẩu học, xã hội và chính trị	14
1.2 Tình hình kinh tế	22
1.3 Tóm tắt các chỉ số y tế	22
1.4 Hệ thống y tế	23
1.5 Tài chính cho y tế	26
2 Nguồn cung nhân lực y tế	30
2.1 Nguồn cung nhân lực y tế	30
2.2 Phân bố nhân lực y tế	32
3 Đào tạo nhân lực y tế	36
3.1 Quản lý đào tạo nhân lực y tế	36
3.2 Năng lực của các cơ sở đào tạo	44
3.3 Tuyển sinh và lựa chọn sinh viên	45
3.4 Quản lý và kiểm định cơ sở đào tạo nhân lực y tế	47
3.5 Đào tạo tại chức và đào tạo liên tục	48
4 Sử dụng nhân lực y tế	50
4.1 Tuyển dụng	50
4.2 Các chính sách và cơ chế phân công và phân bố nhân lực y tế	51
4.3 Thất nghiệp	53
4.4 Tuyển dụng nhân lực y tế trong khu vực y tế tư nhân	53
4.5 Năng lực làm việc của nhân lực y tế	53
5 Cung cấp tài chính cho nhân lực y tế	55
5.1 Chi phí cho nhân lực y tế	55
5.2 Đãi ngộ nhân lực y tế	55
5.3 Cung cấp tài chính cho đào tạo nhân lực y tế	56
6 Quản lý nhân lực y tế	57
6.1 Kế hoạch và chính sách đối với nhân lực y tế	57
6.2 Xây dựng chính sách, kế hoạch và quản lý nguồn nhân lực y tế	58
6.3 Quản lý chuyên môn	61
6.4 Thông tin nhân lực y tế	61
6.5 Yêu cầu về nhân lực y tế	63
7 Kết luận	64
Tài liệu tham khảo	66
Phụ lục	69

Danh mục các bảng

Bảng 1.	Tỷ số giới tính của toàn dân số (số nam/100 nữ).....	16
Bảng 2.	Dân số và tỷ lệ tăng dân số theo các cùng kinh tế xã hội 1999 và 2009.....	18
Bảng 3.	Một số đặc điểm nhân khẩu học.....	21
Bảng 4.	Một số chỉ số kinh tế và kinh tế xã hội	22
Bảng 5.	Một số chỉ số y tế.....	23
Bảng 6.	Số cơ sở y tế và giường bệnh theo tuyến.....	25
Bảng 7.	Một số chỉ số tài chính y tế	29
Bảng 8.	Bao phủ bảo hiểm y tế	29
Bảng 9.	Số lượng cán bộ y tế trong 5 năm qua.....	30
Bảng 10.	Phân bố nhân lực theo trình độ và loại cơ sở y tế.....	31
Bảng 11.	Phân bố một số loại nhân lực y tế theo dân số.....	32
Bảng 12.	Tỷ lệ lao động nữ ở các tuyến tỉnh, huyện và xã năm 2013.....	32
Bảng 13.	Phân bố độ tuổi cán bộ theo các loại cơ sở y tế	33
Bảng 14.	Phân bố các loại nhân lực y tế tuyến tỉnh, huyện và xã theo vùng năm 2013	34
Bảng 15.	Số lượng cơ sở đào tạo nhân lực y tế theo vùng.....	36
Bảng 16.	Nơi đào tạo và sử dụng một số loại nhân lực y tế.....	38
Bảng 17.	Mức thu học phí tối đa đối với các trường đại học công lập.....	42
Bảng 18.	Số cơ sở đào tạo đại học theo phân loại sở hữu.....	44
Bảng 19.	Số sinh viên tốt nghiệp đại học trong những năm gần đây	44
Bảng 20.	Nhu cầu nhân lực cho hệ thống khám chữa bệnh tới năm 2020.....	63
Bảng 21.	Các chỉ tiêu nhân lực chuyên khoa đến năm 2020	63
Bảng 22.	Mô tả nhiệm vụ một số loại nhân lực y tế.....	69

Danh mục các hình

Hình 1.	Thay đổi quy mô dân số từ năm 2000 đến 2012	15
Hình 2.	Mật độ dân cư theo các vùng	15
Hình 3.	Cơ cấu dân số theo giới từ năm 2005 đến 2013	16
Hình 4.	Thay đổi cơ cấu dân số theo thành thị và nông thôn từ năm 2005 đến 2013.....	17
Hình 5.	Tháp dân số 1999 và 2009	18
Hình 6.	Quan hệ giữa các cơ quan sự nghiệp với hệ thống hành chính	25
Hình 7.	Chi y tế từ năm 2011 đến năm 2013	27
Hình 8.	Phân bố chi y tế năm 2013	27
Hình 9.	Hệ thống đào tạo nhân lực y tế	37

Lời cảm ơn

Báo cáo tổng quan quốc gia Việt Nam về nhân lực y tế do cán bộ Viện Chiến lược và Chính sách y tế, đứng đầu là TS. Trần Thị Mai Oanh, Viện trưởng. Nhóm biên soạn gồm ThS. Trần Đức Thuận, Phó Viện trưởng và ThS. Tạ Đăng Hưng, nghiên cứu viên của Viện chịu trách nhiệm tổng hợp tài liệu và biên soạn nội dung.

Tài liệu này được hoàn thành với sự hỗ trợ hậu cần và kỹ thuật từ Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương và Văn phòng Đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam. Các chuyên gia đóng góp ý kiến cho tài liệu này gồm Dr. Gulin Gedik từ Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương, bà Benedicte Galichet của Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam.

Các chuyên viên của một số đơn vị của Bộ Y tế gồm Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ và Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã góp ý và cung cấp thêm tài liệu cho báo cáo này.

Một số cán bộ và nghiên cứu viên của Viện Chiến lược và Chính sách y tế đã tham gia xây dựng và hỗ trợ để nhóm nghiên cứu xây dựng và hoàn thành báo cáo này.

Trân trọng cảm ơn sự tham gia, hỗ trợ của các tổ chức và cá nhân đã giúp chúng tôi hoàn thành tài liệu này.

Danh mục chữ viết tắt

\$US	Đô la Mỹ
APEC	Asia-Pacific Economic Cooperation
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
ASEM	Asia-Europe Meeting
BGDĐT	Bộ Giáo dục và Đào tạo
BLĐT BXH	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
BNV	Bộ Nội vụ
BTC	Bộ Tài chính
BYT	Bộ Y tế
CBR	Tỷ suất sinh thô
CDR	Tỷ suất chết thô
CHS	Commune health station
CKI	Chuyên khoa cấp 1
CKII	Chuyên khoa cấp 2
CLCSYT	Chiến lược và Chính sách y tế
DHS	Điều tra nhân khẩu học và sức khỏe
EBM	Y học thực chứng
GDP	Tổng thu nhập quốc nội
IMR	Tỷ lệ chế trẻ em
KHCNĐT	Khoa học Công nghệ và Đào tạo
KTV	Kỹ thuật viên
MMR	Tỷ số tử vong mẹ
OSCE	Thi lâm sàng có cấu trúc khách quan
OSPE	Thi thực hành có cấu trúc khách quan
PBL	Học tập dựa trên vấn đề
PPP	Sức mua ngang giá
SARS	Hội chứng hô hấp cấp tính nặng
TCTK	Tổng cục Thống kê
TFR	Tổng tỷ suất sinh
U5MR	Tỷ lệ tử vong trẻ dưới 5 tuổi
UBND	Ủy ban Nhân dân
UNDT	Ủy ban Dân tộc
VND	Đồng Việt Nam
WTO	Tổ chức Thương mại thế giới
YTCC	Y tế công cộng

Tóm tắt báo cáo

Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á dân số khoảng 90 triệu người với cấu trúc dân số trẻ. Việt Nam mới trở thành là quốc gia có thu nhập trung bình với GDP khoảng 2000 USD/người/năm. Hệ thống dịch vụ và quản lý y tế được tổ chức theo hệ thống hành chính 4 cấp: trung ương, tỉnh, huyện và xã.

Việt Nam đã đạt được một số mục tiêu thiên niên kỷ như giảm tỷ lệ tử vong mẹ, tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh và trẻ dưới 1 tuổi, tuổi thọ bình quân cũng khá cao 70 đối với nam và 76 đối với nữ. Mô hình bệnh tật và tử vong đang chuyển dịch từ các bệnh truyền nhiễm sang các bệnh không truyền nhiễm. Việt Nam cũng đang phối hợp có hiệu quả với cộng đồng quốc tế để khống chế các bệnh dịch mới nổi như: cúm A, SARS, HIV/AIDS.

Nguồn cung ứng nhân lực y tế

Việt Nam có trên 400.000 nhân viên làm việc trong hệ thống y tế công. Nhân lực chủ yếu gồm bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và lương y chiếm khoảng 80%. Đây là các loại nhân lực cần có chứng chỉ hành nghề theo quy định của luật có hiệu lực từ năm 2011.

Mật độ bác sĩ của Việt Nam là 7,61/1 vạn dân (năm 2013), tỷ lệ điều dưỡng/BS tăng lên đáng kể từ 1,19 (năm 2008) lên 1,34 (năm 2012).

Phân bố nguồn nhân lực

Nữ chiếm tỷ lệ cao hơn nam trong cơ cấu nhân lực chung của hệ thống y tế công. Tuy nhiên, ở khu vực y tế từ tuyến tỉnh trở xuống xã, bác sĩ nam nhiều hơn nữ (nam chiếm 72% số bác sĩ, 83% số bác sĩ chuyên khoa). Ngược lại, điều dưỡng và hộ sinh nữ chiếm tỷ lệ cao hơn nam (63% và 91% theo thứ tự).

Nhóm tuổi dưới 35 chiếm 49,1% tổng số nhân lực chung của các cơ sở cung cấp dịch vụ. Nhóm này chiếm tỷ lệ cao nhất ở khối các trung tâm y tế (85%) và thấp nhất ở các phòng khám đa khoa (11%).

Phân bố nhân lực y tế không đều giữa 6 vùng kinh tế xã hội. Đồng bằng sông Hồng có mật độ nhân lực y tế cao nhất. Đồng bằng Sông Cửu Long và Tây Nguyên có mật độ nhân lực thấp nhất.

Đào tạo nhân lực y tế

Nhân lực y tế được đào tạo với 5 trình độ. Tính từ cao xuống thấp gồm sau đại học có 2 bậc: tiến sĩ hoặc CK II với thời gian đào tạo từ 2 đến 4 năm, thạc sĩ hoặc CK I - 2 năm và bác sĩ nội trú-3 năm đào tạo sau khi xong bậc đại học; đại học 4-6 năm; cao đẳng 3 năm; và trung cấp 2 năm. Từ bậc cao đẳng đến đại học có hai hình thức đào tạo: chính quy tuyển học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông với thời gian chuẩn như trên và liên thông tuyển sinh từ trình độ trung cấp và cao đẳng với một số năm kinh nghiệm làm việc.

Năm 2014, cả nước có 36 trường đại học, 40 trường cao đẳng, và 81 trường trung cấp là các loại cơ sở chính đào tạo nhân lực y tế. Ngoài ra còn có các viện nghiên cứu đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ.

Các cơ sở đào tạo nhân lực y tế hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học. Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan Chính phủ quản lý nhà nước về hoạt động giáo dục nói chung. Bộ Y tế quản lý phần đào tạo CK I, CK II, bác sĩ nội trú và đào tạo liên tục.

Các thách thức lớn nhất với các cơ sở đào tạo hiện nay là: số sinh viên quá đông trong khi chi phí đào tạo được quy định quá thấp so với các nước trong khu vực. Việt Nam thiếu bệnh viện thực hành cho sinh viên. Chương trình và phương pháp đào tạo vẫn mang tính truyền thống chưa hiện đại. Giảng viên còn thiếu

và hạn chế về năng lực chuyên môn. Hệ thống trường tư đang phát triển mạnh trong những năm gần đây song hệ thống kiểm định chất lượng chưa hình thành và cơ chế đảm bảo chất lượng còn yếu.

Chi phí cho đào tạo nhân lực y tế có từ nhiều nguồn khác nhau: do nhà nước cấp, do sinh viên đóng học phí, các nguồn kinh phí hợp tác đào tạo nghiên cứu khoa học, và chi trả từ bên thứ 3 trong các hợp tác đào tạo từ các dự án liên quan đến nhân lực y tế. Học phí do sinh viên nộp thường rất thấp so với nhu cầu chất lượng đào tạo mong muốn. Tuy nhiên, không có thông tin về chi phí cho đào tạo từng loại nhân lực y tế.

Cơ chế giải quyết các vấn đề nhân lực y tế chủ yếu là sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước. Bộ Y tế đã thành lập Ban điều hành phát triển nguồn nhân lực y tế gồm đại diện các Bộ, ngành và các đơn vị liên quan của Bộ Y tế. Ban này tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Y tế các vấn đề về quản lý và phát triển nhân lực y tế. Bộ Y tế thường phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo giải quyết những vấn đề liên quan đến chất lượng đào tạo trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp y tế. Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng y dược là tổ chức tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Y tế về những chính sách, kế hoạch phát triển đào tạo và nghiên cứu khoa học trong các trường y dược.

Tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng y tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm soát thông qua việc tổ chức theo kỳ thi quốc gia hàng năm và quản lý chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở đào tạo.. Ở Việt Nam không tổ chức kỳ thi quốc gia để đánh giá sinh viên tốt nghiệp và cũng không thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề. Đào tạo liên tục được triển khai và là yêu cầu bắt buộc đối với nhân lực y tế để duy trì chứng chỉ hành nghề.

Sử dụng nhân lực y tế

Cơ chế tuyển dụng nhân viên y tế ở khu vực công được thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn dưới luật

Quá trình tuyển dụng nhân lực y tế bắt đầu từ phê duyệt chỉ tiêu nhân lực do các cơ sở đề xuất và các cơ quan chủ quản tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt là các Bộ đối với các cơ sở y tế thuộc các cơ quan trung ương hoặc Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với địa phương. Các ứng viên được đánh giá về văn bằng, kiến thức chung, kiến thức chuyên môn và năng lực ngoại ngữ và sử dụng máy vi tính với một trong hai hình thức là thi tuyển hoặc xét tuyển và chủ yếu do các cơ quan chủ quản thực hiện. Các tỉnh có thể có những chính sách riêng đặc thù để khuyến khích những người có trình độ chuyên môn cao làm việc ở những khu vực hoặc lĩnh vực kém thu hút.

Tài chính cho nguồn nhân lực

Chi phí chung cho hệ thống y tế của Việt Nam năm 2013 là 120.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, không có số liệu về chi phí cho nhân lực y tế. Nhân lực y tế được nhà nước tuyển dụng được trả lương như các lĩnh vực khác. Ngoài lương, nhân viên y tế có thể được hưởng các khoản phụ cấp phụ thuộc vào khu vực và lĩnh vực họ công tác. Có những phụ cấp ưu đãi cho người làm việc ở khu vực có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, ít thu hút hoặc những lĩnh vực nguy hiểm như HIV/AIDS, v.v...

Như đã trình bày ở trên, phần lớn chi phí cho nhân lực y tế được Chính phủ bao cấp đối với các cơ sở đào tạo y tế công lập. Tuy nhiên dữ liệu về tài chính cho nhân lực y tế không được phân loại một cách đầy đủ và chi phí đào tạo cho từng loại nhân lực y tế cũng không sẵn có.

Quản lý nguồn nhân lực

Các chính sách về nhân lực y tế được soi sáng bởi Nghị quyết 46-NQ/TW năm 2005 của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Các chiến lược chính của chính sách nhân lực y tế là: (1) tăng cường nguồn nhân lực về số lượng, chất lượng và cấu trúc; và (2) xây dựng và thực hiện các chính sách đãi ngộ đối với nhân lực y tế.

Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách về nhân lực y tế như: Nghị định số 64/2009/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Nghị định số 56/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập; Nghị định số 134/2006/NĐ-CP quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Quyết định số 1544/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đào tạo nhân lực y tế cho vùng khó khăn, vùng núi của các tỉnh thuộc miền Bắc và miền Trung, vùng đồng bằng sông Cửu Long và vùng Tây Nguyên theo chế độ cử tuyển”

Bộ Y tế đã phê duyệt các kế hoạch về nhân lực y tế nói chung và cho hệ thống khám chữa bệnh nói riêng.

Nhiều cơ quan Chính phủ tham gia vào xây dựng các chính sách về nhân lực y tế, bao gồm Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, v.v... và các cơ quan địa phương.

Hệ thống thông tin về nhân lực y tế có nhiều hạn chế chưa kịp thời cung cấp đầy đủ và chính xác giúp cho công tác lập kế hoạch nhân lực và xây dựng những chính sách phù hợp. Công nghệ thông tin chưa được ứng dụng nhiều trong quản lý nhân lực y tế ngoại trừ hệ thống quản lý cấp chứng chỉ hành nghề đang được thử nghiệm.

1. Giới thiệu

1.1 Thông tin về nhân khẩu học, xã hội và chính trị

Địa lý

Việt Nam là một quốc gia có hình chữ S trên bản đồ nằm ở khu vực Đông Nam Châu Á, trên bán đảo Đông Dương. Việt Nam có biên giới với Trung Quốc ở phía Bắc, với Lào và Campuchia ở phía Tây, phía Đông và phía Nam tiếp giáp với Thái Bình Dương. Diện tích của Việt Nam là 331.211,6 km². Bờ biển Việt Nam dài 3260 km không kể các đảo. Ngoài phần đất liền, Việt Nam có khá nhiều đảo có cư dân sinh sống. Việt Nam chia làm 6 vùng kinh tế - xã hội ứng với các khu vực có địa lý tương đồng:

- Vùng Trung du miền núi phía Bắc với địa hình chủ yếu là núi thấp, đỉnh cao nhất là Fanxipang 3.143m.
- Vùng Đồng bằng Sông Hồng có hình tam giác với diện tích khoảng 15.000 km² nằm trên lưu vực của hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình.
- Vùng Bắc trung bộ và Duyên hải miền trung là một dải đất hẹp, phía tây là núi, phía đông là đồng bằng duyên hải hẹp. Chỗ hẹp nhất chỉ với 50 km.
- Vùng Tây nguyên là vùng cao nguyên rộng lớn

nằm ở phía Tây, địa hình chủ yếu là đất đỏ bazan.

- Vùng Đông Nam Bộ là khu vực địa hình hỗn hợp đồi núi thấp xen lẫn đồng bằng nhỏ hẹp, là khu vực bị sa mạc hóa.
- Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long là khu vực đồng bằng rộng lớn thuộc khu vực châu thổ sông Mekong, khi vào Việt Nam đổ ra nhiều nhánh. Vùng này có khí hậu nhiệt đới.

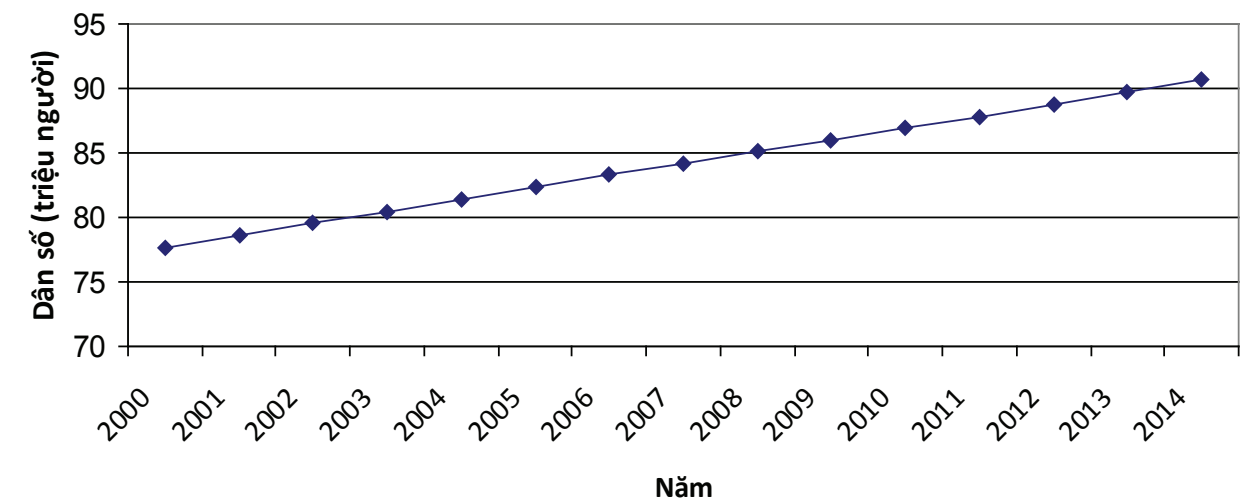
Hà Nội là thủ đô của Việt Nam, nằm ở khu vực Đồng bằng Sông Hồng và Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất nằm giữa khu vực Đông Nam Bộ và Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Nhân khẩu học

Việt Nam là quốc gia đứng thứ 13 trong các quốc gia đông dân nhất thế giới. Dân số Việt Nam trong tổng điều tra năm 2009 là 86,3 triệu, dân số ước tính năm 2014 vào khoảng 90,7 triệu người.

Gia tăng dân số

Việt Nam là một quốc gia có dân số gia tăng tương đối ổn định trong thập niên qua. Năm 2000, dân số Việt Nam là 78 triệu, sau 14 năm (đến năm 2014) dân số cả nước tăng thêm 14 triệu người (Phân bố dân số)



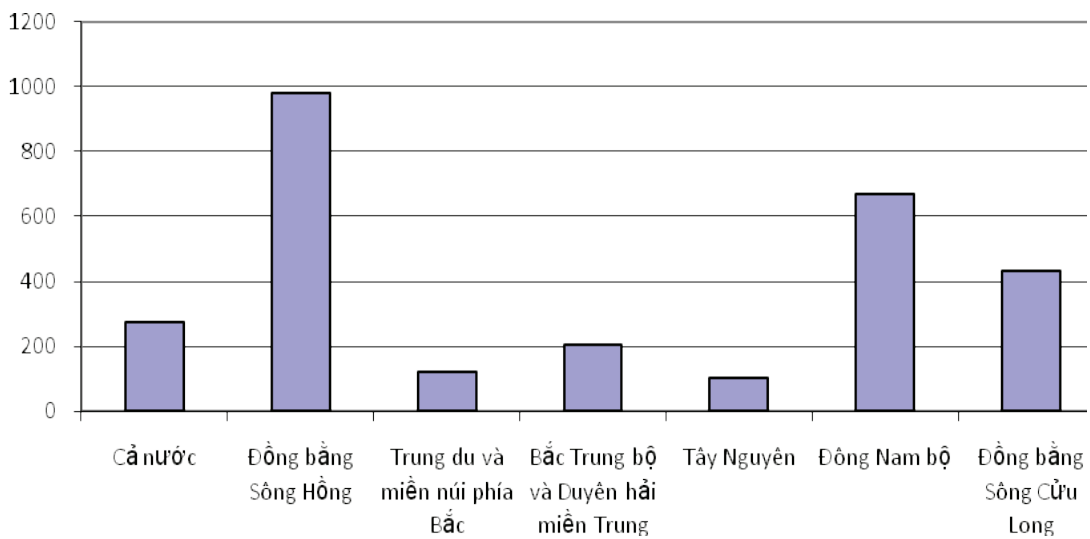
Hình 1 . Thay đổi quy mô dân số từ năm 2000 đến 2012

Nguồn: (TCTK, 2014a)

Phân bố dân số

Mật độ dân số chung cả nước là 274 người/1 km² năm 2014. Dân số Việt Nam tập trung cao ở khu vực Đồng bằng Sông Hồng (983 người/1 km²), Miền

Đông Nam Bộ (670 người/ 1km²), Đồng bằng Sông Cửu Long (432 người/1 km²), Tây Nguyên và Trung du, Miền núi phía Bắc có mật độ dân số thấp nhất trên cả nước (Hình 2).



Hình 2 . Mật độ dân cư theo các vùng

Nguồn: (TCTK, 2014a)

Bảng 1. Tỷ số giới tính của toàn dân số (số nam/100 nữ)

Vùng	2010	2011	2012	2013
Chung cả nước	97,8	97,8	97,8	97,7
Đồng bằng Sông Hồng	97,2	97,5	96,7	97,6
Trung du và Miền núi phía Bắc	99,5	99,3	99,2	98,8
Bắt trung bộ và Duyên hải miền trung	97,9	98,0	97,9	97,6
Tây Nguyên	102,7	103,4	104,1	103,9
Đông Nam bộ	94,5	94,0	94,9	94,6
Đồng bằng Sông Cửu Long	98,8	98,8	98,6	98,3

Nguồn: (TCTK, 2014a)

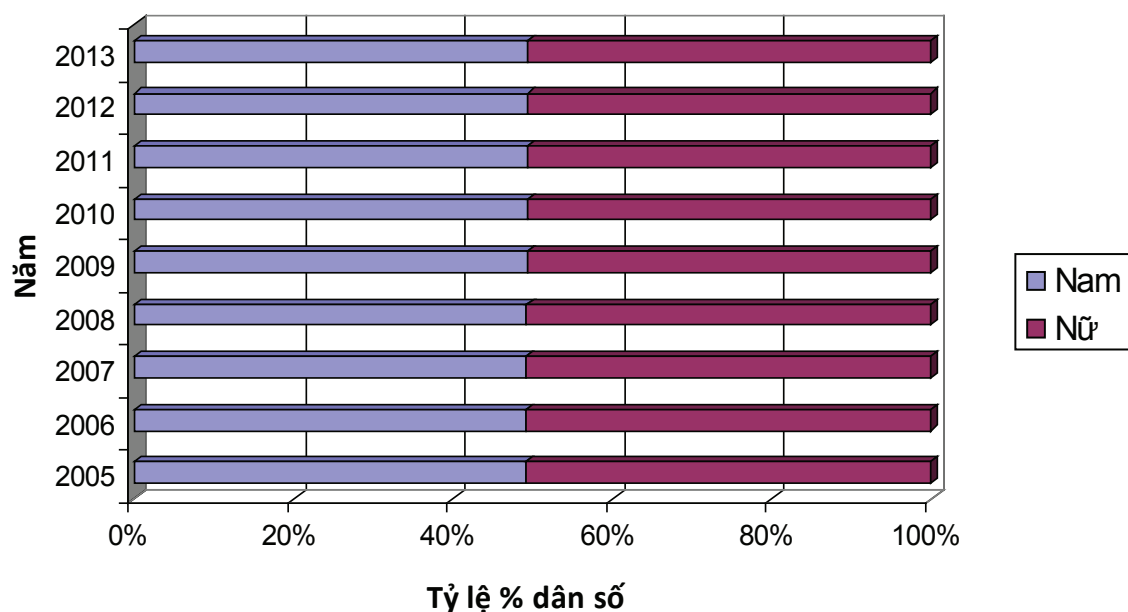
Phân bố dân số theo giới tính

Tỷ số nam và nữ trong dân số Việt Nam thay đổi rất ít trong những năm qua, vào năm 1999 là 96,4/100 (số nam trên 100 nữ) (TCTK, 2009) nhưng vào năm 2013 tỷ số đó là 97,7 (TCTK, 2014a) (Nguồn: (TCTK, 2014a)).

Tỷ số giới tính khác nhau giữa các vùng. Tây Nguyên có tỷ lệ nam đông hơn nữ trong khi hầu hết các vùng và nhìn chung cả nước, nữ chiếm tỷ lệ cao hơn

nam (Bảng 1).

Một trong những vấn đề được Chính phủ quan tâm nhiều là sự mất cân bằng giới tính khi sinh. Ở một số vùng tỷ số giới tính khi sinh rất cao ở mức 120 trẻ trai/100 trẻ gái (TCTK, 2009). Chính phủ đã có chính sách nhằm điều chỉnh vấn đề này như nghiêm cấm thông báo cho sản phụ biết giới tính thai nhi qua bắt mạch, siêu âm; loại bỏ thai nhi vì giới tính (Chính phủ, 2003).

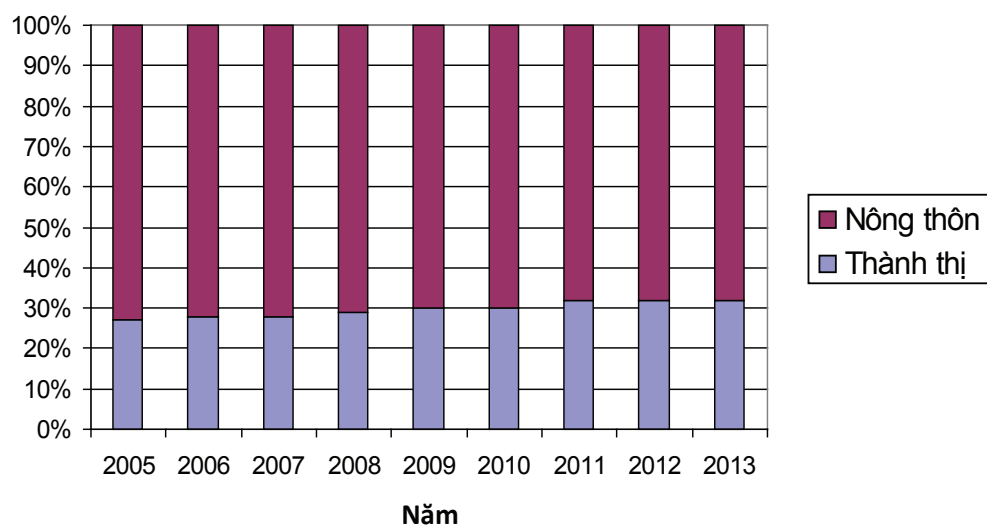


Hình 3. Cơ cấu dân số theo giới từ năm 2005 đến 2013

Nguồn: (TCTK, 2014a)

Phân bố dân cư giữa thành thị và nông thôn

Đô thị hóa ở Việt Nam diễn ra rất nhanh trong thập kỷ qua. Vào năm 2005 có khoảng 27,1% dân cư Việt Nam sống ở thành thị thì năm 2014 tỷ lệ đó là 33,1%. Sự thay đổi về phân bố cơ cấu dân số nông thôn và thành thị đã diễn ra cùng sự phát triển của quá trình công nghiệp hóa mà từ đó mà người dân đã di chuyển ra khu công nghiệp tìm việc làm (Tỷ lệ tăng dân số).



Hình 4 . Thay đổi cơ cấu dân số theo thành thị và nông thôn từ năm 2005 đến 2013

Nguồn: (TCTK, 2014a)

Tỷ lệ tăng dân số

Tỷ lệ tăng dân số ở Việt Nam giảm trong vòng 10 năm qua, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 1999 là 1,7%, năm 2013 là 1,06 %.

Có một sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giữa các vùng. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999 và 2009 cho thấy khu vực có tỷ lệ tăng dân số cao nhất là Đông Nam bộ (3,2%/năm) và Tây Nguyên (2,3%/năm) và thấp nhất là Bắc

Trung bộ và Duyên hải miền Trung (0,4%/năm); tỷ lệ tăng chung cả nước là 1,2%/năm. Sự khác biệt gia tăng dân số này chủ yếu do di dân từ các tỉnh có điều kiện kinh tế xã hội thấp đến các khu vực có điều kiện phát triển kinh tế ở Miền Đông nam bộ và Tây Nguyên (TCTK, 2009). Sự khác biệt này phản ánh nhu cầu dịch vụ y tế cho nhóm tuổi, đặc biệt là nhóm tuổi trẻ, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và các bệnh truyền nhiễm ở lứa tuổi này, đặc biệt là HIV/AIDS.

Bảng 2. Dân số và tỷ lệ tăng dân số theo các vùng kinh tế xã hội 1999 và 2009

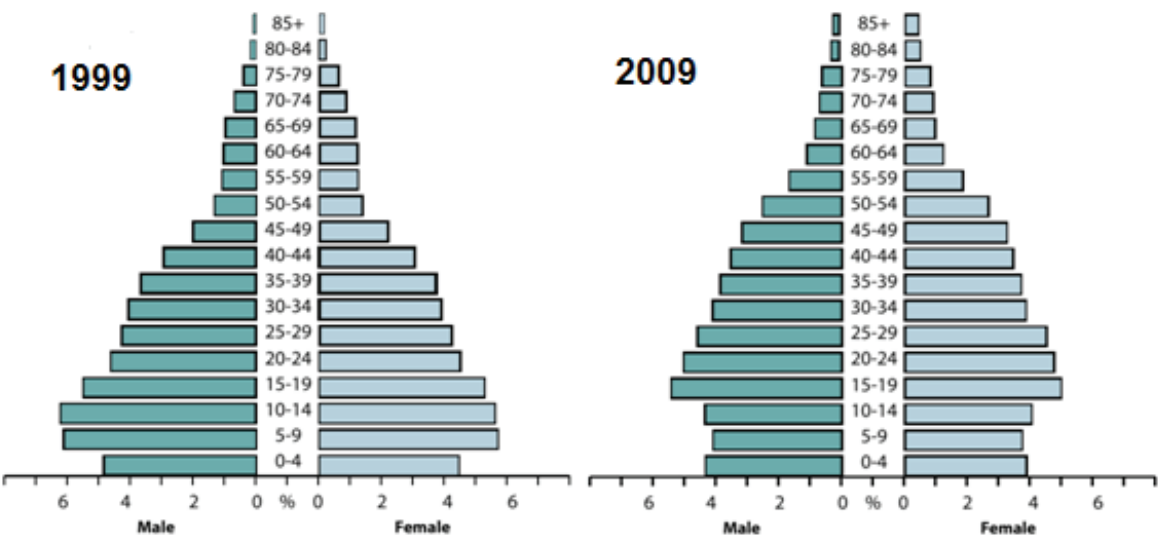
Vùng kinh tế-xã hội	Dân số (người)		Tỷ lệ tăng dân số bình quân năm thời kỳ 1999-2009 (%)
	1999	2009	
Toàn quốc	76 323 173	85 789 573	1,2
Trung du và miền núi phía Bắc	10 033 878	11 064 449	1,0
Đồng bằng sông Hồng	17 852 989	19 577 944	0,9
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung	18 087 097	18 835 485	0,4
Tây Nguyên	4 059 928	5 107 437	2,3
Đông Nam Bộ	10 158 606	14 025 387	3,2
Đồng bằng sông Cửu Long	16 130 675	17 178 871	0,6

Nguồn: (TCTK, 2009)

Phân bố theo tuổi

Số liệu Tổng điều tra dân số năm 1999 cho thấy Việt Nam là nước có dân số trẻ và bắt đầu có tỷ lệ sinh thấp dẫn đến tỷ trọng nhóm tuổi 0-5 thấp. Tổng

điều tra dân số năm 2009 cho thấy cấu trúc dân số có sự thay đổi đáng kể so với 10 năm trước với tỷ trọng của các nhóm tuổi trẻ giảm nhiều (Nguồn: (TCTK, 2011)).



Hình 5. Tháp dân số 1999 và 2009

Nguồn: (TCTK, 2011)

Ngôn ngữ

Tiếng Việt được sử dụng làm ngôn ngữ chính thức ở Việt Nam mà tất cả các nhóm người dân tộc Kinh và những người trẻ dân tộc thiểu số có thể đọc và viết. Tiếng Việt cũng là ngôn ngữ chính thức được giảng dạy tại các trường phổ thông và các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp. Số liệu của tổng điều tra dân số 2009 cho thấy, có khoảng 65,8 triệu người Việt Nam nói tiếng Việt (TCTK, 2009).

Hầu hết người dân tộc thiểu số trẻ tuổi được đi học nói, đọc, và viết được tiếng Việt. Tuy nhiên, có một bộ phận khá đông dân cư dân tộc thiểu số, đặc biệt ở nhóm người cao tuổi hoặc học vấn thấp chủ yếu sử dụng ngôn ngữ của dân tộc mình trong giao tiếp mà ít khả năng sử dụng tiếng Việt. Vấn đề này ảnh hưởng đến tiếp cận thông tin và sử dụng dịch vụ y tế. Để có nhân viên y tế phục vụ các nhóm dân tộc này, Chính phủ đã có chính sách cử tuyển và ưu tiên đào tạo nhân viên y tế từ các dân tộc này và phân công họ làm việc ngay chính trong cộng đồng dân tộc mình (Chính phủ, 2006a)

Tiếng Pháp và Tiếng Nga là hai ngôn ngữ từng được nhiều học giả, trong đó có các bác sĩ được đào tạo từ các nước này sử dụng trước khi Việt Nam mở cửa kinh tế và giao lưu với các nền kinh tế phương Tây.

Hiện nay, Tiếng Anh là ngôn ngữ được giảng dạy ở nhiều cơ sở giáo dục, trong đó có các trường y. Sinh viên có thể sử dụng tiếng Anh để tìm hiểu thông tin, đặc biệt từ internet, phục vụ cho học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp. Chính phủ đang khuyến khích các trường đại học cải tiến chương trình đào tạo và giảng dạy bằng tiếng nước ngoài mà chủ yếu là tiếng Anh (Thủ tướng Chính phủ, 2008).

Ngoài ra, một số ngôn ngữ khác cũng được sử dụng ở Việt Nam như tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga... chủ yếu trong các quan hệ thương mại và trao đổi văn hoá, du lịch mà ít liên quan đến lĩnh vực y tế.

Khái quát về thể chế chính trị

Năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng

hoà, chấm dứt sự đô hộ của Pháp và kết thúc sự thống trị của Nhật sau Chiến tranh thế giới thứ II. Việt Nam có bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946, bản Hiến pháp này đã qua nhiều lần sửa đổi trong các năm 1951, 1959, 1990, 1992 và 2013. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng chính trị duy nhất lãnh đạo toàn diện đời sống kinh tế, xã hội của Việt Nam. Lãnh đạo Đảng được bầu 5 năm một lần thông qua đại hội đại biểu.

Theo Hiến Pháp, Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất với chức năng lập pháp. Quốc hội Việt Nam gồm khoảng 500 thành viên được bầu 5 năm một lần. Quốc hội có quyền ban hành và sửa đổi Hiến pháp, các luật, phê duyệt ngân sách quốc gia, giám sát các hoạt động của Chính phủ và các tổ chức có quyền lực khác, và chỉ định thành viên của cơ quan tư pháp.

Theo Hiến pháp, Chủ tịch nước thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh. Chủ tịch nước giới thiệu Thủ tướng Chính phủ để Quốc hội bỏ phiếu thông qua.

Thủ tướng Chính phủ là đại diện cho cơ quan hành pháp. Giúp việc cho Thủ tướng Chính phủ có các Phó Thủ tướng và tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ có các Bộ trưởng được phân công phụ trách những lĩnh vực cụ thể. Cơ quan hành pháp có trách nhiệm thực thi các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và ngoại giao.

Hệ thống tư pháp của Việt Nam gồm có Tòa án Nhân dân tối cao là cơ quan xét xử, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đóng vai trò công tố.

Ở các cấp hành chính địa phương (tỉnh, huyện, xã) cũng có bao gồm bộ máy tương ứng với cấp trung ương bao gồm: cơ quan lãnh đạo Đảng, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân.

Hệ thống hành chính

Việt Nam có 4 cấp hành chính bao gồm: cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Cả nước chia thành 63 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương

được gọi chung là cấp tỉnh. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được chia thành các huyện, quận, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện). Cấp huyện được chia thành các xã, phường và thị trấn (gọi chung là cấp xã). Năm 2013, cả nước có 708 đơn vị cấp huyện và 11.161 đơn vị hành chính cấp xã (TCTK, 2014b). Hệ thống chính trị ở các cấp được mô tả ở trên.

Hệ thống quản lý hành chính các cấp, trừ cấp trung ương, bao gồm Hội đồng Nhân dân với chức năng lập pháp địa phương và Ủy ban Nhân dân giữ chức năng hành pháp, và Tòa án Nhân dân có ở cấp tỉnh và huyện, Tất cả các cơ quan hành chính hoạt động dưới sự lãnh đạo của tổ chức Đảng và theo Hiến pháp, Pháp luật.

Hệ thống văn bản pháp luật của Việt Nam bao gồm nhiều loại văn bản quy phạm pháp luật. Liên quan đến hoạt động y tế có một số loại văn bản chính sau đây theo thứ tự hiệu lực từ cao xuống thấp gồm Hiến pháp; Luật, Nghị quyết của Quốc hội; Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của các bộ, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, v.v...(Quốc hội, 2015)

Khái quát lịch sử Việt Nam

Việt Nam được ghi nhận là nơi có người tiền sử sinh sống trong khoảng 25.000 năm qua. Nhiều di chỉ khảo cổ ở Việt Nam đã được minh chứng cho sự có mặt của người nguyên thủy và người tiền sử như: văn hóa Phùng Nguyên, Hòa Bình, Đồng Đậu, Đông Sơn, Sa Huỳnh, Ốc Eo.

Nhà nước chính thức đầu tiên của Việt Nam có tên là Văn Lang vào khoảng thế kỷ thứ 7 trước công nguyên, là bộ tộc người Lạc Việt cư trú ở trung du và đồng bằng Sông Hồng.

Khi nhà nước Văn Lang sụp đổ được thay thế bằng nhà nước Âu Lạc và kết thúc năm 208 TCN. Kể từ đó đến 1000 năm sau, Việt Nam là thuộc địa của các triều đại phong kiến phương Bắc. Trong giai đoạn này cũng đã nổ ra nhiều cuộc đấu tranh giành độc

lập tạm thời như: cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40-43 SCN chống lại nhà Đông Hán, cuộc khởi nghĩa Bà Triệu năm 248 SCN chống lại nhà Đông Ngô, cuộc khởi nghĩa của Triệu Quang Phục chống lại nhà Lương, cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan chống lại nhà Tùy, cuộc khởi nghĩa của Phùng Hưng chống lại nhà Đường. 1000 năm Bắc thuộc được kết thúc bởi chiến thắng chống quân Nam Hán do Ngô Quyền lãnh đạo năm 938 và mở đầu cho thời kỳ độc lập. Từ đó qua các triều đại: Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hậu Lê, Mạc, Nguyễn, lãnh thổ Việt Nam dần được mở rộng như ngày nay.

Năm 1858, liên quân Pháp – Tây Ban Nha nổ súng tấn công vào Đà Nẵng xâm lược Việt Nam, bắt đầu giai đoạn Việt Nam dần dần trở thành thuộc địa của Pháp cùng với Lào và Campuchia trên bán đảo Đông Dương. Giai đoạn thuộc địa được kết thúc sau đại chiến thế giới thứ II, và được đánh dấu bằng bản Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Hà Nội ngày 2/9/1945 và ngày 2/9 được lấy làm ngày Quốc khánh của nước Việt Nam. Ngay sau khi Việt Nam tuyên bố độc lập, Pháp quay trở lại và Việt Nam phải trải qua cuộc kháng chiến 9 năm, kết thúc năm 1954 khi Hiệp định Geneva được ký kết và đất nước sau đó bị chia cắt và hình thành hai thể chế: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở phía Bắc vĩ tuyến 17° Bắc và Việt Nam Cộng hòa ở phía nam vĩ tuyến 17° Bắc.

Việt nam trải qua 21 năm chia cắt cùng với cuộc chiến kéo dài có sự can thiệp từ bên ngoài kết thúc vào năm 1975 khi đất nước thống nhất. Năm 1976, cuộc Tổng tuyển cử trên cả nước đã bầu ra Quốc hội và hình thành hệ thống chính trị thống nhất.

Bảng 3. Một số đặc điểm nhân khẩu học

Chỉ số	Giá trị	Năm
Tổng số dân	90.728.900	2014
Tỷ lệ dân số thành thị (%)	33,1	2014
Mật độ dân số	274 người/km ²	2014
Tỷ lệ tăng dân số hàng năm (%)	1,08%	2014
Tỷ lệ di dân (phần nghìn)	2,1‰	2012
Tỷ số giới tính khi sinh	113,8	2013
Phân bố theo nhóm tuổi:		
0-4 tuổi (% tổng dân số)	8,5 %	2013
5-14	15,8 %	2013
15-64	68,5 %	2013
65+	7,2 %	2013
Tổng tỷ suất sinh (TFR)	2,1	2013
Tỷ suất sinh thô (CBR)	17,0	2013
Tỷ suất chết thô (CDR)	7,1	2013
Tỷ lệ biết chữ người lớn	94,7%	2012

Nguồn: (BYT, 2013a) và (TCTK, 2014a)

1.2 Tình hình kinh tế

Từ năm 1975 đến những năm 1980 Việt Nam đi theo con đường xã hội chủ nghĩa với hai hình thức sở hữu toàn dân và tập thể. Từ cuối thập niên 1980 và đặc biệt những năm 1990 trở đi, Việt Nam đi theo hướng đổi mới sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa gồm nhiều thành phần kinh tế và đa hình thức sở hữu. Việt Nam chuyển đổi mạnh mẽ từ một nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường. Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng kinh tế tương đối cao và phát triển nhanh trong những thập niên tiếp sau đổi mới. Hiện nay, Việt Nam đang tham gia vào hầu hết các tổ chức kinh tế quốc tế như: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), tham gia các diễn đàn như ASEM, APEC và hợp tác song phương và đa phương với nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới. Việt Nam phát triển từ một nước nông nghiệp chuyển dần sang một nước công nghiệp, dịch vụ và trở thành nơi thu hút vốn đầu tư nước ngoài tương đối lớn ở khu vực Đông Nam Á. Năm 2013, GDP của Việt Nam đạt 176 tỷ USD dẫn tới thu nhập bình quân đầu người là 1.908 USD (5,293 USD tính theo PPP).

Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế hàng năm của Việt Nam đạt từ 10-15% vào những năm 1990 – 2010. Tuy nhiên, những năm gần đây có giảm xuống còn 6% (TCTK, 2014b).

Nền công nghiệp Việt Nam trước đây chủ yếu gồm những nhà máy, xí nghiệp nhỏ và vừa, chủ yếu chế biến và khai thác. Ngày nay, Việt Nam là nơi thu hút đầu tư của nhiều tập đoàn công nghiệp và thương mại lớn trên thế giới.

Cơ cấu kinh tế của Việt Nam đã có sự chuyển đổi từ chỗ nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, nay nhường chỗ cho công nghiệp và dịch vụ. Tổng sản lượng năm 2013 có cơ cấu nông nghiệp còn 18,38 %, công nghiệp 38,31 %, dịch vụ 43,31 % (TCTK, 2014b).

Bảng 4. Một số chỉ số kinh tế và kinh tế xã hội

Chỉ số	Giá trị	Năm
GDP, hiện tại tính bằng \$US	176 tỷ	2013
GDP đầu người hiện tại, tính bằng \$US	1.908	2013
Tăng trưởng GDP hàng năm (%)	5,42	2013
Tỷ lệ thất nghiệp (%)	3,21	2013
Tỷ lệ lao động (%)	69,5	2012

Nguồn: Theo (TCTK, 2014a)

1.3 Tóm tắt các chỉ số y tế

Các chỉ số y tế của Việt Nam được cải thiện đáng kể trong những thập niên qua. Tuổi thọ bình quân của Việt Nam là 69 tuổi vào năm 2000, tăng lên 73 tuổi vào năm 2013 (IndexMundi, 2015). Việt Nam cũng đã đạt được một số mục tiêu Thiên niên kỷ với một số chỉ tiêu như giảm tử vong mẹ còn 65/100.000 trẻ

để sống vào năm 2013 (BYT, 2013b), cải thiện nhiều so với 170/100.000 vào năm 1990 (IndexMundi, 2015) và tử vong trẻ dưới 5 tuổi còn 23.1‰ năm 2013 (Bảng 5). Việt Nam đã thanh toán bại liệt năm 1997 (xác nhận năm 2000) và loại trừ uốn ván sơ sinh năm 2005 nhờ có tỷ lệ tiêm chủng cao (WHO, 2015).

Bảng 5. Một số chỉ số y tế

Chỉ số	Giá trị	Năm
Tuổi thọ trung bình: - Chung Nữ Nam	73,0	2013
	76	2013
	70	2013
Tỷ lệ chết trẻ dưới 5 tuổi (UMR)	23,1	2013
Tỷ lệ chết trẻ em dưới 1 tuổi (IMR)	15,3	2013
Tỷ lệ tử vong mẹ (MMR)	65/100.000	2013
Tỷ lệ ca sinh được cán bộ y tế có kỹ năng đỡ (% số trẻ sinh)	>97,87%	2013

Nguồn: (TCTK, 2013) and (BYT, 2013a)

Tuổi thọ bình quân của người Việt Nam hiện nay là 70 với nam và 76 với nữ chung cho cả hai giới là 73 tuổi. Chỉ số này thay đổi đáng kể trong những năm qua, năm 1999 tuổi thọ với nam là 65 và nữ là 70; cho đến 2013 tuổi thọ với nam giới đã tăng 5 năm và với nữ đã tăng 6 năm (BYT, 2013a), (BYT, 2013b).

Mô hình bệnh tật của Việt Nam đang chuyển dịch từ các bệnh lây nhiễm sang các bệnh không lây nhiễm là chủ yếu. Ví dụ: năm 1996 tỷ lệ mắc bệnh lây là 37,63%, năm 2013 tỷ lệ này là 25,33%. Năm 2013, tỷ lệ mắc bệnh không lây là 63,5%, trong đó nổi bật là tăng huyết áp, tiểu đường và ung thư (BYT, 2013a).

1.4 Hệ thống y tế

Hệ thống y tế Việt Nam được tổ chức và phát triển mạnh từ những năm 1960, nhiều bệnh viện đã được

xây dựng trên cả nước cùng với hệ thống y tế cơ sở bao phủ hầu hết các xã làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Hệ thống đào tạo nhân lực y tế cũng bắt đầu hình thành và phát triển mạnh mẽ từ những năm 1960.

Hệ thống y tế Việt Nam được tổ chức theo hệ thống hành chính 4 cấp từ xã đến trung ương.

Mỗi đơn vị hành chính cấp xã có một trạm y tế bao gồm từ 5-10 nhân viên tùy theo quy mô dân số. Ngoài ra, các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, trường học, đặc biệt nơi có nhiều công nhân được tổ chức các trạm y tế để phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho dân cư được phân công quản lý.

Cơ quan y tế cấp huyện là trung tâm y tế bao gồm: khối cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh và khối dự phòng. Trong những năm gần đây, cơ cấu tổ chức y tế cấp huyện có thay đổi và không đồng nhất ở tất cả các địa phương. Nhiều huyện được tổ chức gồm: cơ quan quản lý là phòng y tế và các cơ quan sự nghiệp là bệnh viện và trung tâm y tế dự phòng. Ngoài ra, ở cấp huyện còn có các chi cục như: chi cục dân số, chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm làm nhiệm vụ quản lý theo lĩnh vực liên quan ở cấp huyện tùy thuộc vào quy mô dân số và quy định của địa phương.

Cơ quan y tế tuyến tỉnh: gồm cơ quan quản lý nhà nước là Sở Y tế, các cơ quan cung cấp dịch vụ là các bệnh viện đa khoa và bệnh viện chuyên khoa. Các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh thường có quy mô khoảng 500 giường. Các bệnh viện chuyên khoa bao gồm: bệnh viện phụ sản, bệnh viện sản nhi, bệnh viện nhi, bệnh viện y học cổ truyền, bệnh viện lao và bệnh phổi.v.v... Các bệnh viện chuyên khoa được tổ chức tùy theo quy mô dân số của từng tỉnh. Ngoài ra, với những tỉnh có địa bàn rộng có một số bệnh viện đa khoa khu vực được phát triển trên cơ sở bệnh viện tuyến huyện và là cơ sở y tế tuyến trên của một số huyện trong khu vực. Ngoài các bệnh viện, các tỉnh thường có các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế như: trung tâm sức khỏe sinh sản, trung tâm y tế dự phòng, trung tâm phòng chống HIV/AIDS, trung tâm mắt, trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe, chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, chi cục dân số cấp tỉnh. Những cơ sở y tế này thực hiện nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ y tế theo chuyên môn và không có giường bệnh điều trị nội trú. Mỗi tỉnh thường có một trường cao đẳng hoặc trung cấp y tế đào tạo nhân lực y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y học, và được chủ yếu phục vụ nhu cầu của tỉnh.

Tại tuyến trung ương, Bộ Y tế là cơ quan quản lý nhà nước giám sát các hoạt động y tế toàn quốc. Các đơn vị của Bộ Y tế liên quan trực tiếp đến chính sách nhân lực y tế gồm Vụ Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm đề xuất chính sách tuyển dụng, lương và ưu đãi đối với nhân lực y tế; Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đề xuất và giám sát thực hiện các chính sách, quy định về tuyển chọn và các tiêu chuẩn đào tạo nhân lực y tế; Cục Quản lý khám bệnh, chữa bệnh quản lý việc cấp chứng chỉ hành nghề đối với

nhân lực y tế và cấp phép hoạt động cơ sở y tế.

Bộ Y tế quản lý nhiều cơ sở y tế bao gồm các bệnh viện trung ương, các viện nghiên cứu và viện Pasteur và một số trường đại học và cao đẳng y tế. Các bệnh viện gồm đa khoa và chuyên khoa nằm rải rác ở các vùng nhưng tập trung chủ yếu ở thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh. Đây là các bệnh viện tuyến cao nhất của các tỉnh trong khu vực đồng thời cũng là các bệnh viện thực hành của các trường đại học y đóng trên địa bàn. Các viện nghiên cứu bao gồm: Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Dinh dưỡng, Viện Y học lao động, Viện Pasteur của Nha Trang và Thành phố Hồ Chí Minh, v.v... Các cơ sở này vừa làm nhiệm vụ nghiên cứu và đào tạo sau đại học vừa cung cấp các dịch vụ phòng bệnh. Các cơ sở đào tạo gồm một số trường đại học và trường cao đẳng đào tạo ngành y, điều dưỡng hộ sinh, dược và kỹ thuật y học. Phần lớn các cơ sở này do Bộ Y tế quản lý. Hầu hết các trường đại học có bệnh viện thuộc trường với quy mô khoảng 200 giường, làm nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ y tế. Tuy nhiên, số liệu về các bệnh viện thực hành của các trường đại học và cao đẳng không được tổng hợp.

Tuyến	Cơ quan hành chính	Cơ quan quản lý cấp trên	Cơ quan sự nghiệp
Trung ương	Quốc hội		
	Government	Bộ Y tế: Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ,	Bệnh viện trung ương
			Các Viện
			Cơ quan truyền thông, báo
			Trường đại học, cao đẳng y dược
Tỉnh	Hội đồng Nhân dân		
	Ủy ban Nhân dân	Sở Y tế	Các bệnh viện tỉnh
			Các bệnh viện huyện
			Các trung tâm y tế dự phòng
			Trường cao đẳng, trung cấp y
District	Hội đồng Nhân dân		
	Ủy ban Nhân dân	Phòng Y tế	
		Trung tâm y tế huyện/ Trung tâm YTDP huyện	Các trạm y tế xã
Xã	Hội đồng Nhân dân		
	Ủy ban Nhân dân	Không có cơ quan y tế nào đặt dưới sự quản lý của cấp xã	

Hình 6. Quan hệ giữa các cơ quan sự nghiệp với hệ thống hành chính

Ngoài hệ thống y tế được tổ chức theo cấp hành chính, một số ngành cũng tổ chức hệ thống y tế riêng như hệ thống các bệnh viện, phòng khám của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn... quản lý phân bố rải rác trên toàn quốc. Không kể hệ thống quân y, các ngành đang quản lý 785 cơ sở y tế với 12.925 giường bệnh. Các cơ sở y tế đó bao gồm: 26 bệnh viện đa khoa, 17 phòng khám đa khoa, 26 khu điều dưỡng, 6 trung tâm y tế và 710 y tế cơ quan (BYT, 2013a).. Hệ thống quân y được tổ chức riêng và không nằm trong báo cáo này.

Mạng lưới các cơ sở y tế tư nhân được hình thành và phát triển mạnh cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000 khi đất nước khởi xướng công cuộc đổi mới. Mạng lưới này gồm các bệnh viện, các phòng khám, các nhà hộ sinh... Tuy nhiên, mạng lưới mới phát triển

chủ yếu ở các khu vực có mức độ đô thị hóa cao và tập trung đông dân cư. Theo quy định, các bệnh viện tư nhân được thành lập do Bộ Y tế cấp phép, các phòng khám tư nhân do Sở Y tế quy định (Quốc hội, 2009a). Năm 2013 cả nước có 155 bệnh viện tư nhân với số giường đăng ký là 9.500 giường (BYT, 2013a) và trên 30.000 phòng khám và các cơ sở y tế tư nhân khác (BYT, 2015a).

Bảng 6. Số cơ sở y tế và giường bệnh theo tuyến

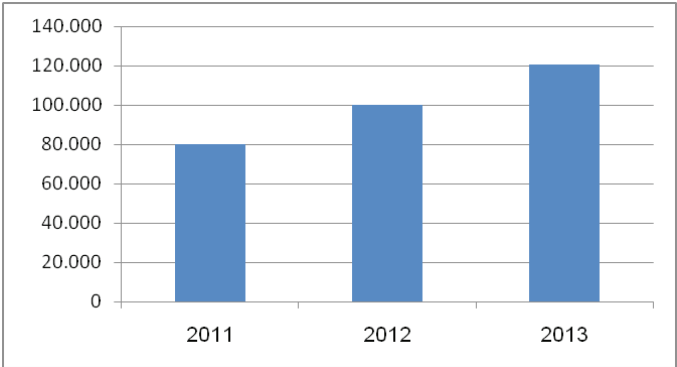
Loại cơ sở y tế	Số cơ sở	Số giường bệnh
Cơ sở y tế công lập		
<i>Trung ương</i>	46	26,756
Bệnh viện đa khoa	17	13,750
Bệnh viện chuyên khoa	23	11,260
Bệnh viện y học cổ truyền	3	1,040
Bệnh viện da liễu	3	706
<i>Địa phương</i>	12,694	236,383
<i>Tuyến tỉnh</i>	447	110,549
Bệnh viện đa khoa	140	66,450
Bệnh viện chuyên khoa	153	30,652
Bệnh viện y học cổ truyền	52	7,220
Bệnh viện da liễu	17	1,445
Trung tâm điều dưỡng và PHCN	37	3,745
Phòng khám chuyên khoa	48	1,037
<i>Tuyến huyện</i>	1,214	77,134
Bệnh viện đa khoa	628	70,547
Phòng khám đa khoa liên xã	574	6,371
Nhà hộ sinh	12	216
<i>Tuyến xã</i>	11,033	48,700
Trạm y tế	11,033	48,700
<i>Cơ sở do Bộ, Ngành khác quản lý</i>	785	12,925
Bệnh viện đa khoa	26	5,035
Phòng khám đa khoa	17	695
Trung tâm điều dưỡng	26	3,790
Trung tâm y tế	6	3,405
Trạm y tế	710	
Bệnh viện tư	155	9,501
Tổng số	13,680	285,565

Nguồn: (BYT, 2013a)

1.5 Tài chính cho y tế

Hệ thống y tế Việt Nam hoạt động chủ yếu từ ngân sách nhà nước cấp và gia tăng hàng năm. Tổng chi ngân sách cho y tế năm 2011 vào khoảng 80.000 tỷ

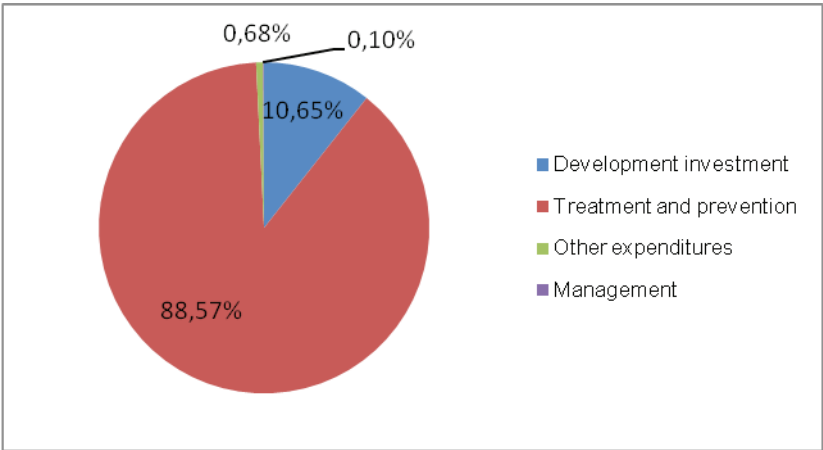
đồng. Năm 2012, ngân sách tăng thêm 25% và năm 2013, tổng ngân sách y tế bằng 1,5 lần năm 2011 (Hình 7. Chi y tế từ năm 2011 đến năm 2013).



Hình 7. Chi y tế từ năm 2011 đến năm 2013

Nguồn: Trích (BYT, 2013a)

Ngoài ngân sách chủ yếu do nhà nước cấp, chi y tế còn được trả từ một số nguồn khác như Bảo hiểm y tế, viện phí thu trực tiếp từ người bệnh và các nguồn thu khác không đáng kể (Hình 8)



Hình 8. Phân bổ chi y tế năm 2013

Nguồn: Theo (BYT, 2013a)

Bảng 7 mô tả cơ cấu chi tiêu y tế năm 2013 chiếm tỷ lệ 3,36% so với GDP cả nước trong khi đó, chi phí cho giáo dục là 16,85%. Tỷ lệ chi y tế so với tổng chi ngân sách nhà nước là 12,3% và chi phí y tế theo đầu người là 63,86 USD (BYT, 2013a), (TCTK, 2014a).

Bảng 7. Một số chỉ số tài chính y tế

Chỉ số	Giá trị	Năm
Tổng chi cho y tế (% GDP)	3,36	2013
Tổng chi cho y tế (% chi Chính phủ)	12.3	2013
Viện phí (người bệnh trả– nghìn tỷ đồng)	15	2013
Chi y tế hàng năm theo đầu người (\$US)	63,85	2013
Chi phí công cho giáo dục (% GDP)	16,85	2013

Nguồn: (TCTK, 2014b) and (BYT, 2013a)

Trong những năm gần đây, chi tiêu y tế từ nguồn bảo hiểm y tế tăng lên từ 20.400 tỷ đồng năm 2011 lên 42.000 tỷ đồng năm 2013. Sự gia tăng nguồn này đi cùng với sự gia tăng số người tham gia bảo hiểm y tế tăng từ 57,1 triệu người năm 2011 lên 62,8 triệu người năm 2013 (Bảng 8).

Bảng 8. Bao phủ bảo hiểm y tế

Chỉ tiêu	2011	2012	2013
Số người tham gia bảo hiểm y tế (triệu người)	57,11	58,98	61,76
Tỷ lệ dân số có thể bảo hiểm y tế (%)	65,01	66,44	70,0

Nguồn: (BYT, 2011a), (BYT, 2012a) and (BYT, 2013a)

2. Nguồn cung nhân lực y tế

2.1 Nguồn cung nhân lực y tế

Việt Nam có 419.542 nhân viên làm việc trong hệ thống y tế nhà nước (TCTK, 2014c). Nhân lực y tế này chủ yếu gồm: bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên và lương y chiếm khoảng 83,55 % (BYT, 2012a) và là loại nhân lực cần có chứng chỉ hành nghề khi làm việc. Ngoài ra, còn có các nhân viên phục vụ khác như dược sĩ, kỹ sư, kế toán, công nhân

kỹ thuật, v.v...

Bác sĩ được đào tạo ở trình độ đại học, bao gồm bác sĩ đa khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt và bác sĩ y học dự phòng. Các bác sĩ sau một thời gian công tác có thể tiếp tục được đào tạo và công nhận trình độ chuyên khoa cấp 1 (CKI) và chuyên khoa cấp 2 (CKII). Một số ít bác sĩ mới tốt nghiệp có thành tích học tập tốt được phép thi tuyển để theo học chương trình bác sĩ nội trú trong thời gian 3 năm. Các bác sĩ này thường làm việc ở các bệnh viện tuyến trung ương.

Bảng 9. Số lượng cán bộ y tế trong 5 năm qua

Loại nhân lực y tế	2009	2010	2011	2012	2013
Bác sĩ	56.661	62.546	64.442	65.135	68.466
Dược sĩ	15.176	15.150	16.875	17.360	19.083
Thạc sĩ và cử nhân y tế công cộng	461	650	925	1.065	1.510
Y sĩ	51.062	52.455	54.487	54.564	55.999
Điều dưỡng đại học	2.736	3.748	5.008	6.114	7.981
Kỹ thuật viên	13.850	14.221	15.185	15.711	17.043
Dược sĩ trung học và kỹ thuật viên dược	38.136	43.090	48.598	43.090	44.328
Điều dưỡng trung học	64.901	70.359	76.787	80.312	83.369
Hộ sinh đại học, cao đẳng và trung học	23.569	25.289	26.495	27.089	27.837
Điều dưỡng sơ học	8.254	7.141	6.224	5.775	5.339
Hộ sinh sơ học	1.429	1.249	1.034	930	799
Lương y	269	264	219	237	229
Dược tá	29.353	22.805	21.329	22.805	22.561
Đại học và sau đại học khác	15.551	16.544	18.206	19.816	21.752
Cao đẳng và trung học khác	9.766	11.785	12.844	13.414	14.294
Cán bộ khác	33.702	35.108	34.258	33.731	33.647
Tổng	364.876	382.404	402.887	407.148	424.237

Nguồn: (BYT, 2013a)

Mật độ bác sĩ sĩ phục vụ năm 2012 là 7,34/10.000 dân (Bộ Y tế, 2012a) đến năm 2013 mật độ này tăng lên là 7,61/10.000 dân. Tỷ lệ điều dưỡng trên bác sĩ

đang tăng lên đáng kể trong thập niên qua. Năm 2008, tỷ lệ đó là 1,19/1, năm 2012 tỷ lệ đó là 1,34/1.

Bảng 10. Phân bố nhân lực theo trình độ và loại cơ sở y tế

Loại nhân lực	Tổng số	Bệnh viện	Trung tâm y tế	Phòng khám đa khoa, chuyên khoa	Trạm y tế cấp xã/phường	Loại hình cơ sở khám, chữa bệnh khác
Tiến sỹ y khoa	1.668	1.043	37	565	0	23
Tiến sỹ dược	71	61	7	3	0	0
Thạc sỹ y khoa	6.052	5.133	504	346	19	50
Thạc sỹ dược	464	394	44	16	5	5
Chuyên khoa I, II y khoa	20.132	15.235	3.247	1.016	463	171
Chuyên khoa I, II dược	1.051	634	156	241	16	4
Bác sỹ	45.160	26.607	6.778	3.617	7.848	310
Dược sỹ đại học	3.771	2.839	562	253	89	28
Cử nhân y tế công cộng	2.397	1.365	653	101	245	33
Y sỹ	62.012	18.394	12.929	2.431	27.904	354
Dược tá	5.324	2.217	613	645	1.787	62
Dược sỹ trung cấp	23.640	12.318	3.980	640	6.594	108
Điều dưỡng	97.704	71.365	9.936	3.950	12.166	287
Kỹ thuật viên y	17.467	12.969	2.767	974	612	145
Kỹ thuật viên dược	2.170	1.358	349	189	248	26
Hộ sinh	28.893	12.500	4.531	872	10.818	172
Lương y	3.616	2.270	490	128	625	103
Trình độ khác	60.846	42.624	9.353	2.756	2.982	3.131
Total	382.438	229.326	56.936	18.743	72.421	5.012

Nguồn: (TCTK, 2014c)

Số lượng nhân lực làm việc trong hệ thống y tế nói chung không thay đổi nhiều trong những năm gần đây.

Nhân lực y tế trình độ chuyên môn cao như tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa chủ yếu làm việc ở tuyến trung ương, gồm các bệnh viện, viện nghiên cứu và các trường đại học. Nhiều cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Y tế, Sở Y tế. Bảng 10 liệt kê số lượng

mỗi loại nhân lực y tế theo loại cơ sở y tế các cơ sở y tế địa phương gồm tuyến tỉnh, huyện và xã.

Mật độ một số loại nhân lực y tế tăng lên trong những năm qua. Đặc biệt mật độ điều dưỡng đã tăng nhanh phản ánh vai trò của loại nhân lực này trong lao động ngành y tế đang dần thay đổi (xem Bảng 11).

Bảng 11. Phân bố một số loại nhân lực y tế theo dân số

Loại nhân lực y tế	2009	2010	2011	2012	2013
Số dân/1 bác sĩ	1.518	1.390	1.378	1.363	1.315
Số bác sĩ/1000 dân	0,66	0,72	0,73	0,73	0,76
Số y và bác sĩ/1000 dân	1,25	1,34	1,34	1,35	1,38
Số điều dưỡng/1000 dân	0,88	0,94	0,99	1,04	1,07
Số dược sĩ đại học/1000 dân	0,18	0,18	0,19	0,20	0,21

Nguồn: (BYT, 2013a)

2.2 Phân bố nhân lực y tế

Phân bố theo giới

Với tổng số nhân lực y tế là 419.542 người, nữ chiếm tỷ lệ cao hơn nam (nữ chiếm 62,22%). Tuy nhiên, ở từng ngành nghề và trình độ khác nhau thì tỷ lệ này thay đổi. Theo số liệu điều tra của Tổng cục Thống kê, bác sĩ nam chiếm tỷ trọng cao hơn nữ (71,8%),

đặc biệt với bác sĩ chuyên khoa tỷ lệ này ở nữ thấp hơn nhiều (chiếm 16,9%). Đối với điều dưỡng, nữ chiếm tỷ lệ cao hơn với 62,6 % và đặc biệt là hộ sinh chủ yếu là nữ chiếm 90,5% (TCTK, 2014c).

Bảng liệt kê tỷ lệ nhân viên y tế là nữ làm việc ở tuyến y tế địa phương gồm tỉnh, huyện và xã năm 2013. Không có số liệu đối với tuyến trung ương.

Bảng 12. Tỷ lệ lao động nữ ở các tuyến tỉnh, huyện và xã năm 2013

Loại nhân lực y tế	Tổng số	Nữ	% nữ
Tiến sĩ y	321	75	23,36
Thạc sĩ y	3827	1337	34,94
Tiến sĩ dược	12	6	50,00
Thạc sĩ dược	205	122	59,51
Bác sĩ	47718	18013	37,75
Bác sĩ nha khoa	608	321	52,80
Dược sĩ đại học	3906	1861	47,64
Thạc sĩ Y tế công cộng	141	44	31,21
Cử nhân Y tế công cộng	1167	546	46,79
Sau đại học khác	471	262	55,63
Đại học khác	15117	9278	61,37
Y sĩ	54158	32652	60,29
KTV nha khoa	203	152	74,88
KTV y	11003	7435	67,57
Dược sĩ trung cấp và KTV dược	19447	15156	77,93
Lương y	159	47	29,56
Dược tá	1499	1173	78,25
Cao đẳng và trung cấp khác	13433	8690	64,69
Khác	19615	12202	62,21

Nguồn: (BYT, 2013a)

Phân bố theo tuổi

Ở Việt Nam, tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động là 55 đối với nữ và 60 đối với nam. Thậm chí, ở một số ngành độc hại như tiếp xúc với yếu tố

phóng xạ, bệnh lây nhiễm tuổi nghỉ hưu có thể được sớm hơn.

Theo điều tra cơ sở y tế, độ tuổi của cán bộ y tế Việt Nam được mô tả như trong Bảng 13.

Bảng 13. Phân bố độ tuổi cán bộ theo các loại cơ sở y tế

Loại cơ sở y tế	Bệnh viện		Trung tâm y tế		Phòng khám đa khoa		Trạm y tế		Loại hình cơ sở khám chữa bệnh khác	
	n	%	n	%	N	%	N	%	n	%
Từ 15-34	116.567	50,83	25.861	85,13	1.032	10,91	32.324	44,63	12.762	30,30
Từ 35-55	104.261	45,46	2.951	9,71	7.274	76,93	38.821	53,60	23.186	55,05
Từ 55-60	7.639	3,33	1.511	4,97	751	7,94	1.239	1,71	3.124	7,42
>60	859	0,37	54	0,18	398	4,21	37	0,05	3.044	7,23
Tổng	229.326	100,00	30.377	100,00	9.455	100,00	72.421	100,00	42.116	100,00

Nguồn: (TCTK, 2014c)

Số liệu trong Bảng 13 cho thấy đa số cán bộ y tế ở độ tuổi từ 15-35 là 49,14%, cao nhất ở khối trung tâm y tế nhóm tuổi này chiếm 85,13%, tiếp theo là khối bệnh viện với 50,83%, thấp nhất ở khối phòng khám đa khoa chỉ với 10,91%.

Phân bố theo địa lý

Nói chung, nhân lực y tế ở Việt Nam phân bố không đều theo các vùng kinh tế xã hội (6 vùng). Số lượng cán bộ y tế theo ngành và trình độ đào tạo được trình bày trong Bảng 14, số liệu này cho thấy nhân lực y tế có mặt nhiều ở vùng Đồng bằng Sông Hồng và Đồng bằng Sông Cửu Long; và có ít ở vùng Tây Nguyên. Tuy nhiên con số đó không phản ánh được sự đáp ứng với nhu cầu của dân cư. Tính theo mật độ nhân lực y tế trên một vạn dân, Đông Nam Bộ có tỷ lệ cao nhất với 71 cán bộ y tế/1 vạn dân. Vùng có tỷ lệ thấp nhất là Đồng Bằng Sông Cửu Long (42 cán bộ y tế/1 vạn dân) và Tây Nguyên (43 cán bộ y tế/1 vạn dân), cao nhất là Đông Nam Bộ với 71 cán bộ y tế/1 vạn dân.

Không chỉ thiếu về số lượng, những khu vực khó khăn như vùng núi Tây Bắc, Tây Nguyên có tỷ lệ cán bộ y tế trình độ cao như bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa thấp hơn các vùng khác rất nhiều.

Theo số liệu thống kê y tế cho thấy điều dưỡng, hộ

sinh, kỹ thuật viên, dược sĩ ở những vùng núi khó khăn chủ yếu là trình độ trung cấp, thậm chí trình độ sơ cấp. Bên cạnh đó, bác sĩ làm việc ở vùng khó khăn chủ yếu là những y sĩ được đào tạo liên thông với chất lượng kỳ vọng thấp hơn các bác sĩ đào tạo 6 năm do chương trình liên thông tuyển sinh thường kém cạnh tranh hơn và sinh viên được đào tạo thời gian ngắn và thực hành ít hơn chương trình 6 năm.

Nhân lực y tế làm việc ở tuyến xã và huyện chủ yếu là nhân lực được đào tạo thời gian ngắn hơn như: điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên trình độ trung cấp, y sĩ, và bác sĩ liên thông. Nhân lực trình độ cao như tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa và tương đương, dược sĩ, điều dưỡng, hộ sinh đại học chủ yếu làm việc ở các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Năm 2011, cả nước có 1226 tiến sĩ y khoa, trong đó 850 đang làm việc ở tuyến trung ương, chiếm 69,3%. Đối với ngành dược tỷ lệ này còn cao hơn, cả nước có 247 tiến sĩ dược, trong đó có 239 đang làm việc ở tuyến trung ương, chiếm 96,76% (BYT, 2011a)..

Bảng 14. Phân bố các loại nhân lực y tế tuyến tỉnh, huyện và xã theo vùng năm 2013

Loại nhân lực y tế	Tổng số	Đồng bằng Sông Hồng	Trung du và miền núi phía Bắc	Bắc trung bộ và duyên hải miền trung	Tây Nguyên	Đồng Nam bộ	Đồng bằng Sông Cửu Long
Tiến sĩ y	321	113	11	41	27	108	21
Thạc sĩ y	3.827	1.264	446	903	125	806	283
Tiến sĩ dược	12	5	-	-	-	7	-
Thạc sĩ dược	205	79	21	28	3	43	31
Bác sĩ	47.718	10.313	8.217	9.845	2.869	7.579	8.895
Bác sĩ nha khoa	608	105	34	109	17	200	143
Dược sĩ đại học	3906	776	635	715	237	653	890
Thạc sĩ YTCC	141	47	4	22	6	47	15
Cử nhân YTCC	1.167	431	152	203	51	151	179
Điều dưỡng đại học	6.811	2.052	1.220	1.325	390	973	851
KTV đại học	2.106	243	94	643	183	647	296
Hộ sinh đại học	1.262	173	152	309	54	271	303
Sau đại học khác	471	143	40	97	26	100	65
Đại học khác	15.117	3.133	1.964	3.477	816	2.838	2.889
Y sĩ	54.158	9.423	12.583	11.969	2.876	5.656	11.651
KTV nha khoa	203	34	16	42	13	53	45
KTV cao đẳng và trung cấp y	11.003	2.054	2.130	2.879	660	1.776	1.504
Dược sĩ trung cấp và KTV dược	19.447	3.152	3.203	3.602	1.110	2.970	5.410
Điều dưỡng cao đẳng và trung cấp	71.140	16.048	10.851	14.350	4.099	13.472	12.320
Hộ sinh cao đẳng và trung cấp	25.076	4.365	3.919	6.124	1.838	3.927	4.903
KTV sơ học y	368	27	20	87	26	131	77
Điều dưỡng sơ học	4.589	399	940	972	505	953	820
Hộ sinh sơ học	785	61	172	222	95	93	142
Lương y	159	30	7	53	12	26	31
Dược tá	1.499	270	256	364	110	300	199
Cao đẳng và trung cấp khác	13.433	2.267	2.229	2.645	983	2.469	2.840
Khác	19.615	4.078	1.921	4.262	1.251	4.898	3.205
Tổng số	305.147	61.085	51.237	65.288	18.382	51.147	58.008

Nguồn: (BYT, 2013a)

Phân bố theo kỹ năng chuyên môn

Như trình bày ở trên các loại nhân lực y tế rất phức tạp khi phân biệt. Nhiều loại nhân lực y tế nay không còn đào tạo nữa như điều dưỡng, hộ sinh, dược tá trình độ sơ cấp trước đây thường đào tạo dưới một năm. Phân bố theo kỹ năng chuyên môn được

tính toán dựa trên số liệu thống kê năm 2013 (BYT, 2013a) và kết quả *điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2012* (TCTK, 2014c).

Cơ cấu nhân lực y tế làm việc trong khu vực y tế công của Việt Nam, bác sĩ chiếm tỷ lệ 16%. Tỷ lệ bác sĩ có

trình độ chuyên khoa chiếm 38% tổng số bác sĩ.

Y sĩ chiếm 13%. Tỷ lệ y sĩ/bác sĩ là 0.82/1. Mật độ y sĩ và bác sĩ trên 1000 dân năm 2013 là 13.72.

Điều dưỡng chiếm tỷ lệ 23% tổng nhân lực y tế công. Tuy nhiên, điều dưỡng trung cấp chiếm tỷ lệ 86% tổng số điều dưỡng. Hiện tại, trong hệ thống còn 5.6% điều dưỡng sơ cấp, được đào tạo trước đây với chương trình 1 năm và hiện nay không còn đào tạo. Tỷ lệ điều dưỡng cao đẳng và đại học chiếm 8.3% do chương trình mới được đào tạo trong thời gian khoảng 15 gần đây. Tỷ lệ chung của điều dưỡng so với bác sĩ là 1.4/1 và tỷ lệ điều dưỡng đại học và cao đẳng/bác sĩ chỉ ở mức 0.12/1.

Hộ sinh chiếm 6.7% tổng số nhân lực y tế công và 2.7% trong số họ là điều dưỡng sơ cấp đào tạo 1 năm từ chương trình cũ, nay không thực hiện. Hộ sinh trình độ đại học mới được đào tạo nên chiếm tỷ lệ không đáng kể trong số hộ sinh.

Dược sĩ chiếm 15% nhân lực y tế công, trong đó 70% là dược sĩ trung cấp. Tỷ lệ dược sĩ đại học so với bác sĩ là 0.29/1.

Bộ Y tế và Bộ Nội vụ phân chia nhân lực y tế làm việc trong hệ thống y tế công lập theo trình độ và kinh nghiệm công tác làm cơ sở cho việc trả lương. Theo hệ thống phân loại này, một bác sĩ được tuyển dụng có thể sẽ thăng tiến từ ngạch bác sĩ, lên bác sĩ chính và tiếp theo là bác sĩ cao cấp (BNV và BYT, 2015). Điều

dưỡng theo thứ tự từ thấp đến cao gồm điều dưỡng sơ cấp, điều dưỡng trung cấp, điều dưỡng, và điều dưỡng chính (BNV, 2005). Tương tự, hộ sinh gồm hộ sinh sơ cấp, hộ sinh trung cấp, hộ sinh, hộ sinh chính (BYT, 2011c), v.v... Phân loại một số nhóm nhân lực y tế cùng mô tả nhiệm vụ và yêu cầu trình độ được trình bày trong Phụ lục.

3. Đào tạo nhân lực y tế

3.1 Quản lý đào tạo nhân lực y tế

Các loại cơ sở đào tạo nhân lực y tế và mối liên hệ giữa Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo trong quản lý đào tạo nhân lực y tế

Có ba loại trường đào tạo nhân lực y tế là trung cấp, cao đẳng và đại học. Ngoài ra, các viện nghiên cứu có thể đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ. Năm 2010, Bộ Y tế đã thí điểm đào tạo CKI, CKII, và bác sĩ nội trú cho một số bệnh viện trung ương. Tuy nhiên, đến nay Bộ Y tế đã dừng thí điểm này và chỉ còn các trường đại học đào tạo các chương trình này.

Cả nước có 36 trường đại học, 41 trường cao đẳng và 80 trường trung cấp đào tạo nhân lực y tế. Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp này có thể là trường đơn ngành (chỉ đào tạo tạo các văn bằng về y tế) hoặc đa ngành (đào tạo nhân lực nhiều ngành khác nhau). Bảng 15 mô tả phân bố các cơ sở đào tạo gồm đại học, cao đẳng và trung cấp theo các vùng kinh tế xã hội trên cả nước.

Bảng 15. Số lượng cơ sở đào tạo nhân lực y tế theo vùng

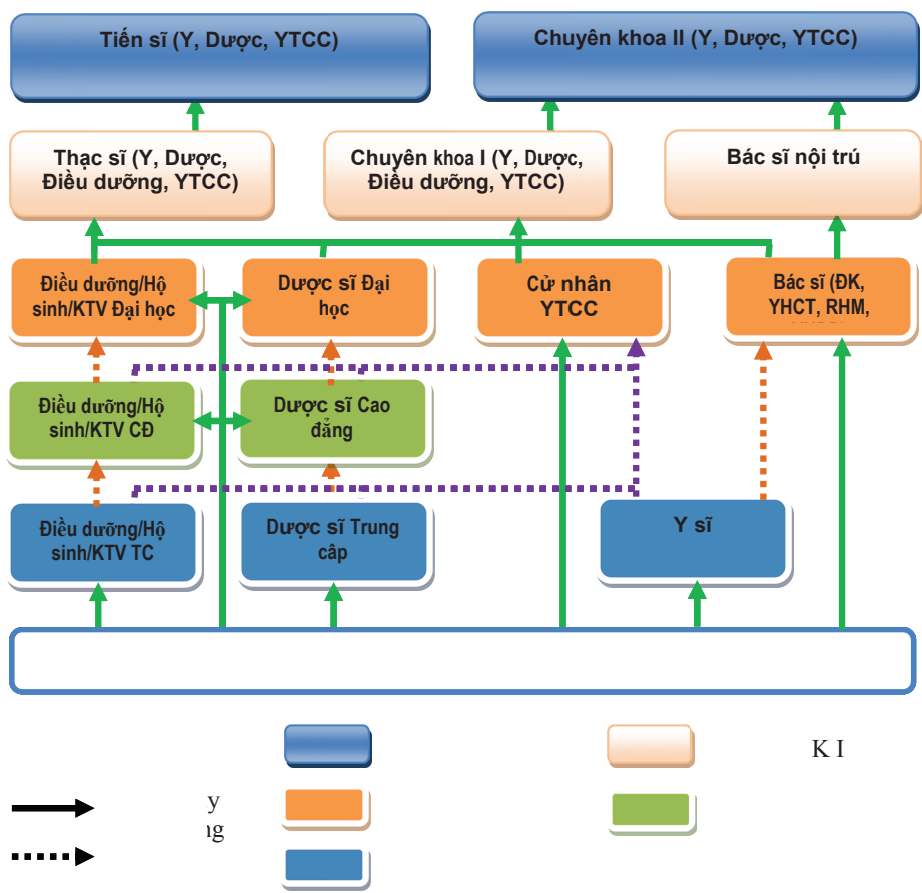
Vùng	Đại học	Cao đẳng	Trung cấp
Trung du và miền núi phía Bắc	15	10	13
Đồng bằng sông Hồng	1	10	22
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung	3	7	11
Tây Nguyên	2	1	4
Đông Nam Bộ	12	5	22
Đồng bằng sông Cửu Long	3	8	9
Tổng số	36	41	81

Nguồn: Tổng hợp từ (BGDDT, 2014)

Hoạt động của các cơ sở đào tạo được quy định trong Luật Giáo dục (ban hành năm 1998, sửa đổi năm 2005, sửa đổi và bổ sung năm 2009), Luật Giáo dục đại học (năm 2011), và Luật Giáo dục chuyên nghiệp (có hiệu lực năm 2015). Chính phủ thống nhất về quản lý giáo dục trên toàn quốc. Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan giúp Chính phủ quản lý nhà nước về giáo dục bao gồm việc quy định về mở trường, mở ngành (Quốc hội, 1998), (Quốc hội, 2005), (Quốc hội, 2009b), (Quốc hội, 2014). Chính phủ phân cấp cho các Bộ, ngành và chính quyền địa phương quản lý các hoạt động giáo dục tùy theo loại trường và trình độ đào tạo (Chính phủ, 2010)..

Mặc dù được quy định trong Luật Giáo dục nhưng hiện nay ở Việt Nam chưa thực hiện hoạt động kiểm định giáo dục độc lập mà mới bắt đầu ở kiểm định nội bộ dựa trên các tiêu chí do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Bộ Y tế là cơ quan quản lý việc sử dụng nhân lực y tế tốt nghiệp từ các cơ sở đào tạo. Bộ Y tế tham gia phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn mở trường, mở ngành và ban hành chuẩn năng lực cho từng loại ngành nghề thuộc nhân lực y tế.



Hình 9. Hệ thống đào tạo nhân lực y tế

Bộ Y tế quản lý các chương trình đào tạo chuyên khoa sau đại học khối ngành khoa học sức khỏe bao gồm CKI, CKII và bác sĩ nội trú (Chính phủ, 2011a). Ngoài ra, Bộ Y tế còn quản lý đào tạo và cập nhật kiến thức y khoa liên tục, đào tạo thực hành trước khi cấp hành nghề cho những người mới tốt nghiệp và cho nhân viên làm việc trong hệ thống y tế theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (Quốc hội, 2009a).

Quá trình và thời gian đào tạo

Quá trình đào tạo bắt đầu từ tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với trình độ đại học và

cao đẳng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi tuyển sinh quốc gia với các môn thi: toán, hóa, sinh (cho ngành y, điều dưỡng, kỹ thuật y học, hộ sinh, y tế công cộng) hoặc toán, lý, hóa (cho ngành dược, y tế công cộng). Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đổi mới tuyển sinh đại học và cao đẳng từ năm 2015 bằng cách kết hợp kỳ thi tuyển sinh với thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tuyển sinh trung cấp được giao cho các trường xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông và theo chỉ tiêu được đăng ký với cơ quan quản lý giáo dục.

Bảng 16. Nơi đào tạo và sử dụng một số loại nhân lực y tế

Chức danh	Số năm được đào tạo	Trường đào tạo	Cơ quan thường tuyển dụng
Bác sĩ	6 năm	Trường Đại học y dược/ Khoa Y-Đại học tổng hợp	Cơ sở y tế tất cả các tuyến
Y sĩ	2 năm	Trường Cao đẳng/ Trung cấp y tế	Trạm y tế xã/phường, bệnh viện/cơ quan y tế tuyến huyện.
Dược sĩ đại học	5 năm	Trường Đại học y dược/ Khoa Dược-Đại học tổng hợp	Các bệnh viện/ cơ quan y tế tuyến trung ương. Các bệnh viện/ cơ quan y tế tuyến tỉnh.
Dược sĩ trung cấp	2 năm	Hệ trung cấp trong trường cao đẳng y tế. Trường trung cấp y tế. Khoa dược – hệ trung cấp trong trường cao đẳng. Trường trung cấp y tế.	Trạm y tế xã/phường. Bệnh viện/ cơ quan y tế tuyến huyện. Cửa hiệu thuốc tư nhân.
Kỹ thuật viên đại học	4 năm	Trường Đại học y dược/ Khoa Y-Đại học tổng hợp	Khoa xét nghiệm/ Chẩn đoán hình ảnh/ thăm dò chức năng các bệnh viện.
Điều dưỡng đại học	4 năm	Trường Đại học Y/ Khoa Y-Đại học tổng hợp/ Đại học điều dưỡng.	Bệnh viện tuyến trung ương, tỉnh. Trung tâm y tế dự phòng tỉnh.
Điều dưỡng cao đẳng	3 năm	Hệ cao đẳng trong trường Đại học Y khoa/ Điều dưỡng. Trường cao đẳng y tế.	Bệnh viện tuyến trung ương, tỉnh.
Điều dưỡng trung cấp	2 năm	Hệ trung cấp trong trường cao đẳng y tế. Trường trung cấp y tế.	Trạm y tế xã/phường. Bệnh viện/trung tâm y tế huyện.
Hộ sinh đại học	4 năm	Trường Đại học Y/ Khoa Y-Đại học tổng hợp/ Đại học điều dưỡng.	Bệnh viện tuyến trung ương, tỉnh. Trung tâm y tế dự phòng tỉnh.
Hộ sinh cao đẳng	3 năm	Hệ cao đẳng trong trường Đại học Y khoa/ Điều dưỡng. Trường cao đẳng y tế.	Bệnh viện tuyến trung ương, tỉnh.
Hộ sinh trung cấp	2 năm	Hệ trung cấp trong trường cao đẳng y tế. Trường trung cấp y tế.	Trạm y tế xã/phường. Bệnh viện/trung tâm y tế huyện.

Chương trình đào tạo do các cơ sở đào tạo xây dựng dựa trên những thông tin đánh giá nhu cầu đào tạo và sự phân bổ quỹ thời gian theo từng trình độ (đại học 4-6 năm, cao đẳng 3 năm, trung cấp 2 năm). Hội đồng khoa học giáo dục nhà trường phê duyệt chương trình đào tạo. Trước đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chương trình khung cho từng ngành học ở tất cả các trình độ. Hiện nay, việc xây dựng và phê duyệt chương trình thuộc quyền của các cơ

sở đào tạo (Quốc hội, 2012) dẫn đến sinh viên tốt nghiệp có các mức độ khác nhau về năng lực, kiến thức và kỹ năng..

Ở Việt Nam, tất cả các chương trình đào tạo nhân lực y tế tuyển sinh người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên và ít nhất 18 tuổi.

Thời gian đào tạo khác nhau tùy thuộc và từng

ngành học và trình độ đào tạo. Có hai hệ đào tạo: đào tạo chính quy tuyển học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và liên thông tuyển sinh người đã có văn bằng chuyên môn ở trình độ thấp hơn và có thời gian làm chuyên môn và thời gian đào tạo thường ngắn hơn chương trình chính quy. Bác sĩ được đào tạo 6 năm với hệ chính quy và 4 năm với hệ liên thông. Dược sĩ được đào tạo 5 năm với chính quy và 4 năm với hệ liên thông. Điều dưỡng, kỹ thuật y học, hộ sinh và cử nhân y tế công cộng đào tạo ở bậc đại học hết 4 năm. Các ngành dược, điều dưỡng, kỹ thuật y học, hộ sinh được đào tạo ở trình độ cao đẳng trong 3 năm hoặc trung cấp trong 2 năm.

Theo quy định của Luật Giáo dục, người tốt nghiệp ở trình độ thấp hơn và trải qua kinh nghiệm công tác có thể được đào tạo liên thông lên trình độ cao hơn. Ví dụ: người tốt nghiệp trung cấp điều dưỡng, sau 2 năm công tác có thể thi tuyển để học liên thông thêm 1 năm để được cấp bằng cao đẳng cùng ngành. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng và có thời gian công tác 2 năm, điều dưỡng có thể học tiếp lên đại học trong thời gian 1 năm. Riêng y sĩ (trình độ trung cấp-2 năm) được phép học liên thông trong thời gian 4 năm để lấy bằng bác sĩ (bác sĩ đa khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ y học dự phòng) (BGDĐT, 2015) Hệ thống các chương trình đào tạo nhân lực y tế được mô tả trong Hình 9. Hệ thống đào tạo nhân lực y tế.

Chương trình đào tạo y khoa và điều dưỡng là các chương trình dựa trên môn học. Sinh viên phải học tuần tự các môn khoa học cơ bản, y học cơ sở và lâm sàng. Bộ Y tế đang hướng dẫn các trường đổi chương trình theo hướng dựa trên năng lực để thay thế chương trình cũ cho phù hợp với chuẩn năng lực mà Bộ mới ban hành.

Về phương pháp đào tạo, trong thời gian dài đào tạo nhân lực y tế được giảng dạy bằng các phương pháp truyền thống. Sau khi học xong lý thuyết ở cơ sở đào tạo, sinh viên được phân công đến các bệnh viện để thực hành trên bệnh nhân và với những trang thiết bị thực tế. Hiện nay, nhiều phương pháp giảng dạy mới đang được giới thiệu áp dụng vào các trường đại học và cao đẳng khối ngành khoa học sức khỏe cùng với các phương pháp đánh giá hiện đại như

OSCE và OSPE. Các trường đại học và cao đẳng được trang bị phòng thực hành kỹ năng hiện đại để sinh viên thực hành kỹ năng trước khi làm việc trên bệnh nhân và trang thiết bị thực.

Thành lập cơ sở đào tạo và xác định năng lực đào tạo

Theo quy định của Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học như đã nêu ở trên, Chính phủ thống nhất quản lý về hoạt động giáo dục và phân cấp trong việc quản lý giáo dục. Việc thành lập cơ sở giáo dục đại học ngành y tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp các Bộ ngành liên quan như Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch đầu tư và có sự tham gia của Bộ Y tế thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thành lập các cơ sở đào tạo cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt với sự tham mưu của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với sự đồng ý của địa phương và ngành y tế. Các cơ sở đào tạo trung cấp được thành lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc các Bộ chủ quản (Chính phủ, 2010).

Chỉ tiêu tuyển sinh vào các cơ sở đào tạo cũng được phân cấp quyết định về cơ bản các cơ sở đào tạo đánh giá nhu cầu nhân lực, tính toán chỉ tiêu dựa trên số cán bộ giảng dạy không quá với tỷ lệ 15 sinh viên/1 giảng viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định (BGDĐT, 2007). Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chỉ tiêu đào tạo cho các cơ sở đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học. Ủy ban Nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương hoặc Bộ chủ quản phê duyệt chỉ tiêu đào tạo của các trường trung cấp thuộc phạm vi quản lý. Thông tin về chỉ tiêu được phê duyệt được đăng trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo và xuất bản trong cuốn sách "Những điều cần biết về tuyển sinh đại học và cao đẳng, trung cấp" để thông báo rộng rãi trên toàn quốc.

Các vấn đề và thách thức đối với các cơ sở đào tạo

Số cơ sở đào tạo nhân lực y tế trình độ đại học ở Việt Nam tương đối ít với số lượng sinh viên tốt nghiệp hàng năm. Ví dụ, có 18 trường đại học y đào tạo cho tốt nghiệp 6889 bác sĩ, cả chính quy và liên thông trong năm 2013. Thách thức lớn nhất đối với các cơ sở đào tạo là quá đông đúc sinh viên trong khi số lượng giảng viên rất hạn chế.

Các bệnh viện thực hành của các trường đại học y ở Việt Nam chủ yếu đưa sinh viên thực hành tại các bệnh viện trung ương hoặc các bệnh viện tỉnh gần với nhà trường nên số lượng cơ sở thực hành tương đối ít so với số lượng sinh viên.

Bộ Y tế đã hướng dẫn kết hợp giữa cơ sở đào tạo và các bệnh viện để giảng dạy thực hành cho sinh viên y và điều dưỡng. Hướng dẫn này yêu cầu các cơ sở đào tạo lựa chọn và ký kết hợp đồng với các bệnh viện cũng như với các cơ sở thực hành khác bao gồm quyền và trách nhiệm của các bên, chia sẻ nguồn lực, v.v... Tuy nhiên, nhiều vấn đề nổi lên như cơ chế tài chính chưa rõ ràng, học phí sinh viên không thể chuyển sang cho bệnh viện, quyền lợi danh dự và công nhận giảng viên chưa rõ ràng, v.v... Bộ Y tế đang phối hợp với các cơ quan Chính phủ liên quan xây dựng các quy định và hướng dẫn tìm kiếm các nguồn tài chính khả thi tạo điều kiện cho kết hợp giữa cơ sở đào tạo và cơ sở thực hành.

Chương trình đào tạo của Việt Nam vẫn mang tính truyền thống với phong cách giáo khoa và hoàn toàn dựa trên kiến thức với sự thiếu linh hoạt. Bộ Y tế đang thúc đẩy việc đổi mới chương trình đào tạo theo hướng dựa trên năng lực. Đây cũng là một thách thức lớn bởi nó làm thay đổi cả hệ thống tổ chức các cơ sở đào tạo cũng như đòi hỏi những nguồn lực và chuyên gia để thực hiện công việc này. Đây cũng là một phần trong đổi mới giáo dục theo hướng học tập tích cực và giáo dục dựa trên năng lực.

Năng lực giảng viên nói chung còn hạn chế. Số lượng giảng viên không đáp ứng được sự gia tăng của sinh viên. Giảng viên ít được cập nhật và nâng cao năng lực, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại và nhu cầu của đào tạo.

Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ đào tạo còn hạn chế, các phòng thí nghiệm, phòng thực hành tiền lâm sàng, các máy móc trang thiết bị thực hành còn lạc hậu chưa đáp ứng nhu cầu đào tạo.

Vấn đề trong phối hợp công tác giữa trường công và trường tư

Giáo dục nhân lực y tế trong lĩnh vực y tế ở Việt Nam được công nhận bình đẳng giữa công và tư trên cơ

sở pháp luật. Hầu hết các cơ sở đào tạo y tế trước năm 1990 là các trường công lập, sau năm 1990 đặc biệt là đầu những năm 2000 xuất hiện nhiều cơ sở đào tạo ngoài công lập. Các cơ sở đào tạo tư thực chủ yếu là các trường trung cấp đào tạo các chương trình điều dưỡng, y sĩ, kỹ thuật viên trong thời gian 2 năm. Tiếp theo là các trường cao đẳng cũng đào tạo chủ yếu là điều dưỡng và dược trong thời gian 3 năm.

Các cơ sở đào tạo công lập được nhà nước cấp kinh phí hàng năm thông qua các cơ quan chủ quản. Ngoài ra, các cơ sở này cũng được thu một phần học phí theo quy định. Các cơ sở đào tạo ngoài công lập hình thành và hoạt động bằng vốn của các tổ chức, cá nhân đóng góp và thu học phí từ học sinh, sinh viên. Mặc dù không có số liệu nhưng thực tế cho thấy mức đóng góp của học sinh, sinh viên trường tư thường lớn hơn trường công.

Giữa trường công và trường tư trên danh nghĩa không có mối quan hệ hợp tác hay hỗ trợ. Tuy nhiên, trong những năm trước đây, các trường tư thường không tổ chức thi tuyển sinh quốc gia mà dựa vào kết quả tuyển sinh được tổ chức bởi các trường công lập để tuyển chọn sinh viên cho trường mình. Nhiều giảng viên các trường tư được tuyển chọn từ những người có kinh nghiệm giảng dạy ở các trường công và đã nghỉ hưu. Ngoài ra, cũng có một số giảng viên đương nhiệm tại các trường công kiêm nhiệm giảng dạy tại các trường tư, tuy nhiên không có con số cụ thể. Luật Giáo dục cho phép các trường nhận giảng viên thỉnh giảng do vậy ngoài giảng viên cơ hữu, các trường kể cả công và tư đều được phép sử dụng giảng viên thỉnh giảng của nhau và của các cơ sở khác như bệnh viện, viện nghiên cứu hay cơ quan quản lý nhà nước.

Nhiều bệnh viện công hợp tác làm cơ sở thực hành với cả trường công và trường tư. Do vậy, nhiều giảng viên lâm sàng thuộc biên chế của các bệnh viện có hợp đồng giảng dạy thực hành lâm sàng cho cả trường công và trường tư, đặc biệt khi bệnh viện mà họ làm việc là cơ sở thực hành cho cả trường công và trường tư.

Mặc dù không có dữ liệu chính thức nhưng có thông

tin cho thấy các nhà quản lý và bác sĩ ở nhiều cơ sở thực hành lâm sàng sẵn sàng phối hợp với các trường tư hơn là trường công bởi cơ chế và mức độ chi trả của trường tư thuận lợi hơn trường công (Viện CLCSYT, 2015).

Chi phí cho đào tạo nhân lực y tế

Chi phí cho đào tạo có từ nhiều nguồn: (i) do nhà nước cấp, (ii) từ học phí từ sinh viên hoặc từ các nguồn hỗ trợ học bổng, (iii) từ hợp đồng đào tạo cho những chương trình, dự án phát triển nhân lực cụ thể, (iv) kinh phí được cấp cho các hoạt động nghiên

cứu khoa học, (v) thu từ các dịch vụ khác như: dịch vụ y tế, dịch vụ nghiên cứu khoa học, tư vấn kỹ thuật.

Học phí ở các cơ sở đào tạo công lập được thu một phần từ sinh viên. Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2015-2016 to 2020-2021” trong đó quy định mức thu học phí bậc đại học của các trường công như được trình bày trong Bảng 17.

Bảng 17. Mức thu học phí tối đa đối với các trường đại học công lập

Đơn vị: nghìn đồng/tháng/sinh viên

Nhóm ngành	Academic year 2015 -2016 to 2017 -2018	Academic year 2018 -2019 to 2019 -2020	Academic year 2020 -2021
1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản	1.750	1.850	2.050
2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch	2.050	2.200	2.400
3. Y dược	4.400	4.600	5.050

Nguồn: (Chính phủ, 2015)

Ở Việt Nam hiện chưa có một nghiên cứu nào cung cấp số liệu đáng tin cậy về chi phí đào tạo cho từng chương trình đào tạo nhân lực y tế.

Cơ chế phối hợp giải quyết vấn đề nhân lực y tế

Ban Điều hành phát triển nguồn nhân lực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập gồm các thành viên là trưởng các vụ, cục phụ trách các lĩnh vực như y tế dự phòng, y học cổ truyền, khám chữa bệnh, sức khỏe bà mẹ trẻ em, khoa học và đào tạo, đại diện các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo. Quy chế hoạt động của Ban điều hành được ban hành theo Quyết định số 3651/QĐ-Bộ Y tế (BYT, 2012b). Chức năng của Ban Điều hành là tư vấn, tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Y tế về công tác đào tạo, tuyển dụng, quản lý, sử dụng, xây dựng chế độ chính sách để phát triển nguồn nhân lực y tế. Ban Điều hành có 2 nhiệm vụ là: thứ nhất, tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Y tế xây dựng chính sách, chiến lược, kế hoạch, quy hoạch trong đào tạo, tuyển dụng,

quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực y tế. Thứ hai, phối hợp hoạt động giữa Bộ Y tế với các bộ, ngành liên quan, phối hợp giữa Bộ Y tế và các nhóm đối tác trong lĩnh vực đào tạo, tuyển dụng, quản lý, sử dụng và phát triển nhân lực y tế.

Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp ban hành các quy chế về phát triển nhân lực y tế như quy định đào tạo liên thông, ban hành các chương trình khung giáo dục, quy định về đào tạo sau đại học trong lĩnh vực y tế.

Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch quy định về biên chế nhân lực cho các cơ sở y tế (BYT và BNV, 2007). Thông tư này hướng dẫn định mức biên chế trong các cơ sở y tế nhà nước thuộc các Bộ, ngành và địa phương, bao gồm các cơ sở khám, chữa bệnh (bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh, trung tâm y tế có giường bệnh); các cơ sở y tế dự phòng và các trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng y khoa do Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập gồm thành viên là hiệu trưởng của các trường đại học và cao đẳng đào tạo nhân lực y tế và thường trực là Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo của Bộ Y tế. Hội đồng này có chức năng tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Y tế về chủ trương, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Bộ Y tế trong hoạt động quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đặc biệt là các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực giáo dục (BGDDT, 2011).

Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành xác định các chỉ số về nhân lực y tế cần đào tạo, các nhiệm vụ, giải pháp của các cơ sở đào tạo và định hướng phát triển các cơ sở đào tạo trên cả nước (BYT, 2012c).

Từ năm 2000 đến nay, Bộ Y tế có một số dự án có sự hỗ trợ về tài chính và chuyên gia quốc tế đã tiến hành một số hoạt động tiến tới tăng cường và chuẩn hóa nhân lực y tế.

Dự án Tăng cường năng lực giảng dạy trong 8 trường đại học y do Hà Lan hỗ trợ đã giúp các trường nâng cao năng lực giảng viên, tiếp cận với các phương pháp giảng dạy mới trong y khoa, xây dựng chuẩn kiến thức, thái độ, kỹ năng đối với bác sĩ đa khoa, nâng cao năng lực đánh giá sinh viên và đổi mới chương trình đào tạo. Chương trình giáo dục mới được xây dựng được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt cùng với áp dụng phương pháp giảng dạy mới như PBL and EBM. Các trường được đầu tư phòng thực hành kỹ năng tạo điều kiện sinh viên được thực hành trước khi sang học ở bệnh viện với những tình huống thực.

Thực hiện Điều 24 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh yêu cầu bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ sinh, v.v... mới tốt nghiệp phải có thời gian thực hành trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề, một chương trình thực hành nghề nghiệp đang được xây dựng nhằm phát triển năng lực cho bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên đang được Bộ Y tế xây dựng. Quy định về chương trình đào tạo này đang được thảo luận và có thể được thực hiện thí điểm ở một số tỉnh với sự hỗ trợ kỹ thuật từ một số trường

đại học y hàng đầu trong giai đoạn 2016-2017.

3.2 Năng lực của các cơ sở đào tạo

Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất các tiêu chuẩn về tỷ lệ sinh viên/giảng viên đối với từng ngành học trong cơ sở đào tạo nhân lực y tế để xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường. Theo quy định này, số sinh viên và giảng viên cần được chuẩn hóa và quy đổi theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Một nghiên cứu cho thấy cơ sở vật chất của các trường đại học y chưa đáp ứng đủ yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo như còn thiếu giảng đường, thư viện nghèo nàn và còn khác biệt lớn giữa các trường về kết cấu hạ tầng, trình độ giảng viên, và môi trường thực hành chuyên môn.

Bảng 18 cho thấy số cơ sở đào tạo đại học từng ngành và phân theo loại sở hữu. Số liệu này thay đổi thường xuyên trong những năm qua do xuất hiện mới nhiều cơ sở đào tạo. Số cơ sở đào tạo tương đối ít so với số sinh viên tốt nghiệp từng ngành trong Bảng 19. Điều này phản ánh năng lực đào tạo bị hạn chế và có thể là yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo.

cho thấy số cơ sở đào tạo đại học từng ngành và phân theo loại sở hữu. Số liệu này thay đổi thường xuyên trong những năm qua do xuất hiện mới nhiều cơ sở đào tạo. Số cơ sở đào tạo tương đối ít so với số sinh viên tốt nghiệp từng ngành trong Bảng 19. Điều này phản ánh năng lực đào tạo bị hạn chế và có thể là yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo.

Bảng 18. Số cơ sở đào tạo đại học theo phân loại sở hữu

Loại cơ sở đào tạo	Số lượng theo loại hình sở hữu*		Tổng
	Công	Tư	
Y	15	2	17
Răng hàm mặt	7	0	7
Y học cổ truyền	1	0	1
Điều dưỡng	15	8	23
Dược	10	7	17
Kỹ thuật y học	9	1	10
Y tế công cộng	7	1	8

Nguồn: Tổng hợp từ (BGDĐT, 2014)

*Chú thích: Một cơ sở đào tạo có thể đào tạo nhiều ngành

Bảng 19. Số sinh viên tốt nghiệp đại học trong những năm gần đây

Trình độ, chuyên ngành	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Đại học hệ chính quy	2.335	2.490	2.685	2.900	3.530	4.330	5.365	5.980
BS đa khoa	1.550	1.580	1.730	1.760	2.090	2.240	2.450	2.550
BS Y học cổ truyền	90	90	100	140	110	160	400	510
BS Răng-Hàm-Mặt	145	150	160	170	230	240	340	360
BS Y học dự phòng							50	260
Dược sỹ	410	530	580	690	800	1.080	1.135	1.140
CN Điều Dưỡng	140	140	115	140	300	610	990	1.160
CN kỹ thuật y học	135	130	210	200	200	250	450	568
CN Y tế công cộng	165	190	180	270	260	180	230	383
Liên thông	1.660	1.460	1.820	1.745	2.090	2.150	2.378	3.209
BS đa khoa	1.400	1.160	1.430	1.235	1.260	1.240	1.250	1.889
BS Y học cổ truyền	80	90	100	130	280	330	400	454
BS YHDP	180	210	290	380	550	580	728	866
Vừa làm vừa học	300	370	730	1.200	1.570	1.800	1.930	2.689
CN Điều Dưỡng	195	250	560	930	1.250	1.470	1.530	2.182
CN Kỹ thuật y học	105	120	170	190	180	180	230	308
CN Y tế công cộng				80	140	150	170	199
Đại học bằng 2						47	148	155
Dược sĩ						47	148	155
Tổng	4.295	4.320	5.235	5.845	7.190	8.327	9.821	12.033

Nguồn: (Cục KHCNĐT, 2013)

Số lượng tốt nghiệp năm 2013 so với 2006 tăng ở tất cả các loại hình đào tạo , cao nhất là đối với cử nhân điều dưỡng tăng 998% (3.342 so với 335), thấp nhất là bác sĩ đa khoa tăng 150% (4.439 so với 2.950). Điều này cũng phù hợp với hoàn cảnh thực tế, trong giai đoạn những năm 2000 cả nước có nhu cầu nhân

lực y tế rất cao, nên ngành y tế đã đẩy mạnh đào tạo.

3.3 Tuyển sinh và lựa chọn sinh viên

Quy trình tuyển sinh

Việc tuyển sinh vào các cơ sở đào tạo y tế nói riêng và các cơ sở giáo dục đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp nói chung được thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi năm 2009 và Luật Giáo dục năm 2011. Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất hướng dẫn tổ chức và giám sát việc tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục.

Hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh theo đề nghị của các trường đại học và cao đẳng, chính quyền tỉnh hoặc các Bộ/ngành phê duyệt chỉ tiêu cho các trường trung cấp. Chỉ tiêu được đề xuất phụ thuộc vào điều kiện của nhà trường, thông thường là tỷ lệ sinh viên/giảng viên không vượt quá quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo quy định của luật từ năm 2014 trở về một số năm trước Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất tổ chức thi 3 chung trong đó các trường đại học sẽ đăng ký và được Bộ giao cho tổ chức thi tuyển sinh theo các khối thi ở các khu vực. Đối với các trường đại học thuộc lĩnh vực y tế, các ứng viên sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông phải dự thi các môn thuộc khối B (Toán, Hóa, Sinh) cho các ngành y, điều dưỡng, kỹ thuật y học, y tế công cộng, khối A (Toán, Lý, Hóa) đối với ngành dược. Tuyển sinh quốc gia vào các trường đại học được thực hiện tháng 7 hàng năm.

Các thí sinh ở những khu vực khác nhau được hưởng những ưu tiên khác nhau tính bằng điểm thi. Đối với thí sinh sinh sống ở khu vực miền núi được hưởng ưu tiên 2 điểm, đối với thí sinh sinh sống ở khu vực nông thôn được hưởng ưu tiên 1,5 điểm, các đô thị nhỏ được hưởng 1 điểm. Ngoài ra, điểm ưu tiên còn áp dụng cho những thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt như con thương binh, con liệt sĩ, là anh hùng lao động

Thí sinh được tuyển vào trường đã đăng ký khi tổng số điểm thi kể cả ưu tiên không thấp hơn điểm trúng tuyển do nhà trường công bố dựa trên tổng số thí sinh

được chọn lấy từ tổng điểm cao xuống thấp và không vượt quá chỉ tiêu.

Một số trường cao đẳng được phép sử dụng kết quả thi vào các trường khác làm điểm xét tuyển. Có những trường cao đẳng tổ chức thi vào đợt riêng cũng do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thường tổ chức vào tháng 9 hàng năm.

Hầu hết các trường tư thục không tổ chức tuyển sinh và xét tuyển dựa trên kết quả tuyển sinh của các trường công lập cùng khối tuyển sinh.

Các trường trung cấp thường tổ chức xét tuyển dựa trên kết quả học tập trung học phổ thông và không vượt quá chỉ tiêu theo như đăng ký.

Từ năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đổi mới công tác tuyển sinh theo hướng kết hợp kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi tuyển sinh đại học, các thí sinh sẽ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 6 môn, trong đó có 3 môn bắt buộc (Toán, Văn, Ngoại ngữ) và 3 môn tự chọn, do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Kết quả đợt thi này được dùng để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp.

Đối với chương trình học liên thông cho những người đã có văn bằng nghề nghiệp muốn học nâng cao trình độ (trung cấp lên cao đẳng, cao đẳng lên đại học), việc tuyển sinh do các cơ sở đào tạo tổ chức và xét tuyển.

Cử tuyển được áp dụng đối với các thí sinh là người dân tộc thiểu số, sống tại khu vực miền núi, có học lực trung học phổ thông loại khá trở lên, do các tỉnh lựa chọn theo chỉ tiêu được phân bổ theo ngành học, được cử đi học tại các trường Đại học, Cao đẳng và trung cấp mà không phải qua kỳ thi tuyển. Các thí sinh này thường được bồi dưỡng thêm 1 năm dự bị củng cố lại kiến thức phổ thông rồi mới học chương trình chính thức (Chính phủ, 2006a), (Thủ tướng Chính phủ, 2007a).

Số lượng thí sinh dự tuyển theo ngành học và cơ sở đào tạo

Chưa có số liệu thí sinh theo từng ngành học và từng bậc học. Một số lý do không có được thông

tin này, có thể do việc tuyển sinh được tổ chức theo nhiều cấp khác nhau, nhiều đối tượng khác nhau, trong khi chưa có một cơ chế thống nhất bằng một cơ sở dữ liệu. Hơn nữa, một thí sinh có quyền lựa chọn nhiều nguyện vọng, được thi nhiều lần nên khó tổng hợp để có một dữ liệu chính xác. Số liệu tổng hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo thường không chi tiết theo từng ngành học, đặc biệt là các ngành y, điều dưỡng, kỹ thuật y học, dược, và hộ sinh.

Sinh viên bỏ học hàng năm

Không có số liệu tổng hợp về số sinh viên bỏ học. Tuy nhiên, thông thường sinh viên học các ngành y, dược, điều dưỡng thường theo học đến cùng và nhận bằng tốt nghiệp để tiếp tục thực hành nghề nghiệp. Ở Việt Nam, nghề y là nghề được xã hội tôn trọng, điểm trúng tuyển vào ngành y thường cao hơn so với tất cả các ngành khác.

3.4 Quản lý và kiểm định cơ sở đào tạo nhân lực y tế

Theo quy định của Luật Giáo dục, Chính phủ thống nhất quản lý tất cả các hoạt động giáo dục trên lãnh thổ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan giúp Chính phủ thực hiện việc quản lý hoạt động giáo dục thông qua việc xây dựng trình Chính phủ, hoặc ban hành các văn bản quy chế, chính sách quản lý các hoạt động giáo dục.

Luật Giáo dục cũng quy định về kiểm định chất lượng giáo dục. Luật này quy định tất cả các cơ sở giáo dục phải tự đánh giá chất lượng giáo dục và phải tuân thủ việc kiểm định của cơ quan có thẩm quyền về chất lượng giáo dục. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập các cơ quan kiểm định giáo dục; quy định các điều kiện thành lập và giải thể các cơ quan kiểm định giáo dục (Quốc hội, 2012).

Thi quốc gia đánh giá năng lực bác sĩ, điều dưỡng và hộ sinh

Ở Việt Nam, hiện chưa có quy định về việc tổ chức thi sát hạch quốc gia cho các bác sĩ, điều dưỡng và hộ sinh. Không có các kỳ thi chuẩn quốc gia được triển khai trong quá trình đào tạo và tốt nghiệp.

Chương trình đào tạo y khoa, điều dưỡng và hộ sinh

của Việt Nam trong những năm gần đây mặc dù có nhiều thay đổi nhưng về cơ bản vẫn dựa trên chương trình khung thống nhất trên cả nước cho các ngành cụ thể. Trong chương trình khung đó, có quy định về các học phần, thời lượng và cách thức đánh giá từng học phần đồng thời cũng quy định về việc thi tốt nghiệp. Sinh viên y, điều dưỡng, hộ sinh trước khi tốt nghiệp đều phải hoàn thành tất cả các học phần, đồng thời đảm bảo kết quả thi các môn tốt nghiệp đủ điều kiện mới được cấp bằng tốt nghiệp. Đối với các môn thi tốt nghiệp sinh viên phải thi cả lý thuyết và thực hành để đánh giá kiến thức, thái độ và kỹ năng.

Cơ chế kiểm định cơ sở đào tạo nhân lực y tế

Kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục được quy định trong Luật Giáo dục 2005, sửa đổi 2009, và Luật Giáo dục đại học 2011. Luật quy định việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục, đồng thời quy định tất cả các cơ sở đào tạo phải được kiểm định. Việt Nam đang trong giai đoạn hình thành hệ thống kiểm định giáo dục cho tất cả các lĩnh vực và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở đào tạo thực hiện kiểm định nội bộ trước khi kiểm định độc lập. Các tiêu chí kiểm định chủ yếu tham khảo từ các quốc gia có kinh nghiệm (Quốc hội, 2012). Bộ Y tế đã xây dựng các tiêu chí kiểm định chủ yếu dựa trên kinh nghiệm của một số quốc gia và các tổ chức quốc tế có điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam.

Hiện tại các chương trình giáo dục chưa được kiểm định, nhưng Việt Nam đã có kế hoạch theo hướng đánh giá dựa theo nghề nghiệp và cuối cùng là kiểm định chương trình đào tạo ở mỗi trình độ và chuyên ngành.

Cơ chế và mức độ thường xuyên cập nhật chương trình đào tạo

Luật Giáo dục quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chương trình khung thống nhất cho các ngành học. Các cơ sở đào tạo xây dựng và trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chương trình khung (Quốc hội, 2005). Tuy nhiên, đối với các chương trình thuộc khối ngành khoa học sức khỏe bao gồm: y, điều dưỡng, hộ sinh, dược, kỹ thuật y học... do Bộ Y

tế chỉ đạo. Nhóm chuyên gia xây dựng chương trình do Bộ Y tế tổ chức gồm đại diện cho các ngành học từ một số trường đại học, cao đẳng, trung cấp tiến hành rà soát, khảo sát và đề xuất nội dung chương trình mới phù hợp với yêu cầu của các cơ quan quản lý nhân lực (một số Vụ/Cục chức năng của Bộ Y tế). Chương trình này được hội đồng thẩm định chương trình của khối ngành khoa học sức khỏe do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định thẩm định và trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Chương trình khung cho bác sĩ đa khoa (6 năm), điều dưỡng (4 năm), và dược đại học (5 năm) được ban hành năm 2001, và được sửa chữa cập nhật năm 2012.

Trên cơ sở chương trình khung, các trường phát triển chương trình giáo dục, cụ thể hóa mục tiêu và nội dung của từng môn học cách lượng giá và đánh giá sinh viên theo từng môn học và đánh giá tốt nghiệp.

Bộ Y tế gần đây đã thẩm định các tài liệu đào tạo dùng chung, chủ yếu do các trường có kinh nghiệm đào tạo lâu năm biên soạn để khuyến cáo các cơ sở đào tạo sử dụng làm tài liệu hướng dẫn học tập.

3.5 Đào tạo tại chức và đào tạo liên tục

Đào tạo tại chức của hai khu vực công và tư

Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định mỗi cá nhân tham gia khám chữa bệnh phải có chứng chỉ hành nghề và để duy trì chứng chỉ đó cần có 48 giờ đào tạo liên tục trong 2 năm. Bộ Y tế ban hành hướng dẫn đào tạo liên tục cho người hành nghề y tế trong đó quy định về thời gian đào tạo cũng như trách nhiệm của các cơ quan trong việc tổ chức và quản lý các hoạt động đào tạo (BYT, 2013b). Tuy nhiên, chưa có một cơ chế đánh giá và rà soát việc chấp hành những quy định này. Hơn nữa, các khoá đào tạo liên tục chủ yếu được tổ chức ở tuyến trung ương và tuyến tỉnh do vậy nhân viên y tế ở tuyến dưới có thể sẽ có ít cơ hội tham gia.

Hầu hết đào tạo liên tục được thực hiện ở các cơ sở đào tạo công lập bao gồm các trường, các bệnh viện và các viện nghiên cứu.

Tổ chức, điều phối, kế hoạch, tài chính và quản lý đào tạo liên tục

Bộ Y tế thống nhất quản lý hoạt động đào tạo liên tục đối với nhân lực y tế. Bộ ban hành thông tư hướng dẫn việc tổ chức, thẩm định chương trình, cấp chứng nhận về đào tạo liên tục. Bộ Y tế phân cấp cho các sở y tế địa phương, một số trường, bệnh viện trung ương thẩm định chương trình tài liệu đào tạo liên tục thông qua một hội đồng tư vấn.

Tái cấp chứng chỉ hành nghề và yêu cầu đào tạo liên tục

Cấp chứng chỉ hành nghề ở Việt Nam là cấp 1 lần và sử dụng vĩnh viễn. Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, để duy trì hiệu lực của chứng chỉ hành nghề, người hành nghề phải đảm bảo có tổng thời gian được đào tạo liên tục ít nhất 48 giờ học trong 2 năm. Để được tái cấp chứng chỉ hành nghề nếu chứng chỉ bị thu hồi do không đáp ứng yêu cầu đào tạo, người hành nghề phải nộp chứng nhận đào tạo liên tục tới cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề cùng với những hồ sơ khác giống như yêu cầu khi cấp mới (Quốc hội, 2009a).

4. Sử dụng nhân lực y tế

4.1 Tuyển dụng

Cơ chế tuyển dụng

Cơ chế và cách thức tuyển dụng nhân lực y tế cho khu vực công lập theo các quy định và hướng dẫn của Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ về tuyển dụng viên chức.

Căn cứ trên chỉ tiêu được cơ quan có thẩm quyền, thường là Sở Nội vụ của tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhân sự của Bộ đối với cơ quan trung ương phê duyệt, cơ quan tuyển dụng nhân lực thông báo nhu cầu và chỉ tiêu tuyển dụng thông qua phương tiện thông tin đại chúng để các ứng viên chuẩn bị hồ sơ dự tuyển.

Về cơ chế xây dựng chỉ tiêu, hàng năm cơ sở y tế rà soát lại nhu cầu nhân lực và đề xuất với cơ quan chủ quản (Hình 6). Cơ quan chủ quản sẽ báo cáo cơ quan chịu trách nhiệm phân bổ nhân lực cho tất cả các lĩnh vực. Ở cấp tỉnh, Sở Y tế là cơ quan quản lý hệ

thống y tế của tỉnh, tổng hợp nhu cầu nhân lực và đề xuất kế hoạch tuyển dụng sang Sở Nội vụ và Sở Nội vụ báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với tham mưu của Sở Nội vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng cho các ngành, trong đó có y tế. Trên cơ sở chỉ tiêu đó, Sở Y tế tổ chức tuyển dụng cho ngành y tế của tỉnh.

Bộ Y tế và các Bộ khác phê duyệt kế hoạch nhân lực cần thiết cho các đơn vị trực thuộc. Các Bộ có thể tuyển dụng hoặc thường uỷ quyền cho các đơn vị trực thuộc tuyển.

Có hai hình thức tuyển: thi tuyển và xét tuyển (BNV, 2012). Các ứng viên được tuyển dựa trên các tiêu chí về văn bằng, thể hiện hiểu biết về kiến thức chung, chuyên môn, tiếng Anh và vi tính. Kết quả trúng tuyển được xét từ người có điểm cao nhất xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Tuyển dụng nhân lực y tế mới tốt nghiệp trong khu vực công lập

Chưa có dữ liệu đầy đủ về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp được tuyển vào các cơ quan y tế công lập. Tuy nhiên, có một nghiên cứu điều tra 463 bác sĩ và điều dưỡng tốt nghiệp hệ chính quy ra trường năm 2005-2008, tại thời điểm năm 2008, 79,6% bác sĩ và 87,5% điều dưỡng đã tìm được việc làm (Cường, 2011a).

Tuyển dụng nhân lực cho khu vực nông thôn

Dữ liệu y tế cho thấy khu vực đô thị thường có đông nhân lực y tế hơn ở nông thôn, điều này có thể giải thích bằng một số lý do. Thứ nhất, thành phố là nơi tập trung nhiều cơ sở y tế, đặc biệt là có các cơ sở y tế tuyến trung ương, các bệnh viện thực hành cho các trường đại học y. Thứ hai, xu hướng di chuyển của nhân lực y tế bậc cao (bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa) về thành phố được thể hiện rõ trong một số nghiên cứu (Viện CLCSYT, 2010).

Chính sách tuyển sinh và tuyển dụng áp dụng cho các khu vực nông thôn và đặc biệt là những vùng khó khăn đã tăng số lượng nhân lực y tế. Chính sách cử tuyển và đào tạo liên thông từ y sĩ thành bác sĩ (chương trình 4 năm) tuyển nhiều người của những khu vực này vào các trường đại học y khoa sau đó họ

trở về địa phương hành nghề. Chính sách cho phép các trường cao đẳng và trung cấp y tế địa phương đào tạo y sĩ và điều dưỡng trung cấp và cao đẳng cung cấp thêm nhiều nhân lực cho các trạm y tế và cơ sở dịch vụ y tế tuyến huyện. Một số tỉnh có chính sách tạo điều kiện chỗ ở và tuyển dụng để thu hút người lao động có trình độ đại học và sau đại học làm việc trong khu vực nông thôn. Bộ Y tế mới bắt đầu một đề án thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

4.2 Các chính sách và cơ chế phân công và phân bổ nhân lực y tế

Thay đổi nhân lực y tế

Không có số liệu về tỷ lệ nhân viên y tế rời khỏi ngành. Tuy nhiên, trong những năm gần đây do phát triển y tế tư nhân và đặc biệt với sự ra đời của các bệnh viện tư xuất hiện một làn sóng nhân viên ở một số bệnh viện công xin thôi việc và chuyển sang bệnh viện tư.

Việc sắp xếp lại nhân viên y tế thường diễn ra trong các cơ sở y tế. Cán bộ y tế có thể được chuyển từ đơn vị này sang đơn vị khác theo nguyện vọng cá nhân hoặc sắp xếp của tổ chức. Bộ phận tổ chức cán bộ của cơ quan chủ quản thường thực hiện nhiệm vụ phân công và điều động giữa các cơ quan thuộc quyền. Giám đốc cơ sở quyết định điều chuyển nhân viên trong nội bộ cơ quan.

Thời gian làm việc trung bình của các loại nhân lực y tế

Chưa có nghiên cứu nào cho thấy số giờ làm việc trung bình của từng loại nhân lực y tế. Theo quy định của luật lao động Việt Nam, thời gian làm việc 1 ngày là 8 giờ và 1 tuần là 40 giờ. Nhân viên y tế làm việc ở các cơ sở dịch vụ y tế có trách nhiệm tuân thủ quy định này. Ngoài thời gian làm việc ban ngày, nhân viên y tế đặc biệt những người làm việc ở các bệnh viện còn phải làm việc theo ca trực. Thời gian nghỉ bù cũng được sắp xếp, tuy nhiên ở một số cơ sở thiếu nhân lực thì thời gian phải làm việc ngày và đêm của nhân viên y tế có thể cao hơn thời gian quy định.

Nhân viên y tế vắng mặt và nhân lực “ma”

Chưa có nghiên cứu nào cho biết về nhân viên vắng mặt và lý do vắng mặt cũng như nhân viên “ma”.

Các chính sách khuyến khích và động viên nhân lực y tế

Chính phủ và Bộ Y tế cùng các Bộ khác đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích động viên nhân lực y tế như thưởng tiền hàng tháng, danh hiệu thi đua, điển hình tiên tiến. Một nghiên cứu cho thấy trên 62,9 % bác sĩ hài lòng với công việc của mình và 58,1 % bác sĩ hài lòng với cơ hội được đào tạo tại chỗ (Anh, 2012)..

Hệ thống quản lý

Hệ thống quản lý hành chính, cơ quan cao nhất quản lý là chính phủ, Bộ Y tế là cơ quan tham mưu cho chính phủ về việc quản lý các hoạt động y tế trên cả nước. Trong Bộ Y tế có nhiều đơn vị với chức năng tham mưu cho Bộ trưởng.

Ở cấp tỉnh, UBND tỉnh chịu trách nhiệm quản lý hoạt động y tế trong phạm vi tỉnh. Sở Y tế là đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh về quản lý các hoạt động y tế.

Đối với cấp huyện, hiện nay tồn tại nhiều mô hình khác nhau. Thứ nhất là mô hình bệnh viện huyện và phòng y tế độc lập có chức năng riêng biệt trong đó bệnh viện là cơ quan sự nghiệp cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, còn phòng y tế là cơ quan quản lý giám sát các hoạt động y tế trên địa bàn huyện. Mô hình thứ 2 là trung tâm y tế, tồn tại từ đầu thập niên 1980, vừa là cơ quan chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ y tế, khám chữa bệnh, dự phòng vừa có chức năng quản lý nhà nước về hoạt động y tế của tuyến huyện và tuyến xã. Do có nhiều vấn đề xuất hiện phức tạp với hệ thống y tế tuyến huyện thiếu tính thống nhất, Bộ Y tế đang tích cực tìm ra một mô hình phù hợp cho tuyến huyện.

Cơ quan quản lý có chức năng, nhiệm vụ theo dõi, giám sát các hoạt động y tế trên địa bàn trong đó có các bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế dự phòng và các cơ sở dịch vụ y tế khác đồng thời phân bổ nguồn lực theo kế hoạch hàng năm phê duyệt cho các đơn vị trong phạm vi được phân công quản lý. Các cơ sở y tế có trách nhiệm báo cáo với các cơ

quan quản lý định kỳ hoặc đột suất theo yêu cầu của cơ quan quản lý về tình hình hoạt động y tế của đơn vị mình.

Ở các đơn vị y tế cụ thể ví dụ như bệnh viện, nhiệm vụ quản lý được giao cho ban lãnh đạo gồm giám đốc và các phó giám đốc với sự tham mưu của các phòng chức năng như: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch - tài chính, Phòng Y vụ... và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn là của các khoa/phòng chuyên môn như Khoa nội/nhi, Khoa ngoại/sản, Phòng khám... Đứng đầu các khoa/phòng chuyên môn là các trưởng và phó khoa/phòng chịu trách nhiệm chủ yếu chỉ đạo giám sát với các nhân viên trong khoa/phòng.

Mỗi trạm y tế có 1 trưởng trạm chịu trách nhiệm chung, các nhân viên khác được phân công phụ trách những lĩnh vực cụ thể và công tác quản lý có liên quan.

Cơ chế giám sát

Hoạt động của các cơ sở y tế được giám sát bởi các cơ quan quản lý nhà nước thông qua báo cáo gửi tới các cơ quan nhà nước hoặc các cuộc kiểm tra, thanh tra định kỳ hoặc đột suất.

Giám sát về hoạt động chuyên môn dựa trên hệ thống chỉ đạo tuyến. Đối với dịch vụ y tế các bệnh viện trung ương hoặc bệnh viện hạng 1, hạng đặc biệt ở Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ về mặt chuyên môn cho tuyến dưới. Các bệnh viện tuyến tỉnh và các trung tâm chuyên khoa (ví dụ bà mẹ trẻ em, y tế dự phòng...) giám sát chuyên môn các đơn vị tương ứng của tuyến huyện. Tuyến huyện thì chịu trách nhiệm giám sát chuyên môn của tuyến xã. Các đơn vị chịu trách nhiệm giám sát thường có kế hoạch giám sát. Hoạt động giám sát thường đi kèm với đào tạo đặc biệt với những chương trình y tế có hỗ trợ ngân sách.

Bộ Y tế có đề án 1816 với nội dung các bệnh viện tuyến trên cử cán bộ chuyên môn xuống hỗ trợ tuyến dưới trong thời gian ít nhất 3 tháng 1 người. Đề án này góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho tuyến dưới (Cường, 2011b).

Môi trường làm việc và tiếp cận tới trang thiết bị

Hệ thống các bệnh viện công của Việt Nam trong thời gian gần đây đã được nâng cấp bằng những nguồn đầu tư đáng kể từ chính phủ thông qua các đề án đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các bệnh viện đa khoa huyện, tỉnh và các trạm y tế xã. Với nguồn đầu tư này, trên 600 bệnh viện/trung tâm y tế huyện và nhiều bệnh viện tỉnh, bao gồm cả bệnh viện chuyên khoa và đa khoa. Các bệnh viện này cũng được đầu tư những trang thiết bị hiện đại cho bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện. Các bệnh viện trung ương cũng được đầu tư với những trang thiết bị tối tân như: máy cắt lớp, máy cộng hưởng từ, máy PET-CT, các thiết bị phân tích máu, sinh hóa hiện đại. Ngoài ra, các trạm y tế cũng được nâng cấp và cung cấp trang thiết bị như máy siêu âm, điện tim, những dụng cụ tiểu phẫu, v.v... và đào tạo nhân lực bằng ngân sách từ các dự án hỗ trợ y tế vùng.

4.3 Thất nghiệp

Không có dữ liệu về tỷ lệ thất nghiệp đối với nhân lực y tế.

4.4 Tuyển dụng nhân lực y tế trong khu vực y tế tư nhân

Ở Việt Nam chưa có số liệu về nhân lực y tế làm việc trong hệ thống y tế tư nhân. Tuy nhiên, trong những năm gần đây số lượng cơ sở y tế tư nhân tăng lên đáng kể bao gồm cả phòng khám, dịch vụ, y tế gia đình. Điều đó gián tiếp phản ánh một số lượng nhân lực đang gia tăng hoạt động trong cơ sở y tế tư nhân. Các cơ sở y tế tư nhân thường tuyển dụng những cán bộ nòng cốt cơ hữu là những người có kinh nghiệm đã làm việc trong cơ sở y tế nhà nước và đã nghỉ hưu. Ngoài ra, các cơ sở y tế này còn hợp đồng với các bác sĩ đang làm việc tại các bệnh viện do cán bộ y tế được phép hành nghề y tế tư nhân ngoài giờ khi đang thuộc biên chế ở các cơ sở y tế công lập. Theo luật Lao động quy định, cán bộ làm thêm ngoài giờ không được làm quá 200h/1 năm. Tuy nhiên, chưa có số liệu cụ thể và chưa có một nghiên cứu nào đánh giá về tỷ lệ này.

4.5 Năng lực làm việc của nhân lực y tế

Cơ chế đảm bảo chất lượng

Bộ Y tế là cơ quan quản lý nhà nước và ban hành

các quy chuẩn kỹ thuật và các tiêu chí đánh giá chất lượng của các cơ sở cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Bộ Y tế cũng ban hành các tiêu chuẩn phân hạng bệnh viện, phân tuyến kỹ thuật cho các cơ sở y tế. Hàng năm, Bộ Y tế tổ chức các cuộc kiểm tra chéo bệnh viện theo mẫu lựa chọn. Các thành viên đoàn đánh giá được chọn từ các bệnh viện và cơ quan quản lý của Bộ Y tế.

Các Sở Y tế cũng chịu trách nhiệm quản lý, giám sát hoạt động của các cơ sở dịch vụ y tế và đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn, tiêu chí do Bộ Y tế ban hành.

Ở Việt Nam chưa có hệ thống kiểm định chất lượng bệnh viện độc lập.

Hệ thống đánh giá hoạt động chuyên môn

Bộ Y tế ban hành bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng bệnh viện (BYT, 2013c). Dựa trên tiêu chuẩn này, hàng năm Bộ Y tế và các Sở Y tế của các tỉnh tổ chức đánh giá các bệnh viện trong phạm vi quản lý.

Không có tiêu chuẩn đánh giá cụ thể đối với nhân viên y tế. Tuy nhiên, như các viên chức nhà nước nói chung, hàng năm tất cả nhân lực y tế đều được đánh giá bởi đồng nghiệp và lãnh đạo cơ quan. Những người được đánh giá tốt có thể được đề xuất khen thưởng, thậm chí được tăng lương trước kỳ hạn. Đây cũng có thể là điều kiện tốt để được thăng chức hoặc được cử đi đào tạo cao hơn.

Hệ thống kỷ luật

Nhân viên y tế có thể bị kỷ luật khi có đủ chứng cứ kết luận vi phạm hoặc có sai sót trong chuyên môn. Luật khám bệnh chữa bệnh có quy định về việc xử lý kỷ luật đối với những người vi phạm quy chế chuyên môn. Hội đồng kỷ luật của cơ quan chịu trách nhiệm xem xét và đề xuất hình thức kỷ luật. Người đứng đầu đơn vị sẽ là người ra quyết định kỷ luật. Trong những trường hợp vi phạm nặng có thể truy cứu hình sự để các cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án sẽ là các cơ quan tham gia và quyết định.

5. Cung cấp tài chính cho nhân lực y tế

5.1 Chi phí cho nhân lực y tế

Tổng chi tiêu y tế của Việt Nam năm 2013 là 120.498 tỷ VND (tương ứng với US \$ 5,7 tỷ). Ngân sách dành cho đào tạo nhân lực là 671,1 tỷ VND, bằng 0,56% so với tổng chi y tế do Bộ Y tế quản lý (BYT, 2013a). Chi tiêu chi nhân lực y tế ở địa phương không được báo cáo đầy đủ cả nước.

Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2012/ND-CP về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập. Nghị định chỉ ra lộ trình áp dụng giá dịch vụ y tế được trả từ Bảo hiểm y tế hoặc thu trực tiếp từ bệnh nhân. Năm 2013, giá dịch vụ y tế được tính toán dựa trên chi phí trực tiếp chỉ bao gồm 1) thuốc và các vật tư tiêu hao; (2) chi phí điện, nước, xử lý chất thải và vệ sinh môi trường; (3) bảo dưỡng duy tu trang thiết bị trực tiếp sử dụng cho dịch vụ; và (4) chi phí trực và bổ dưỡng thủ thuật, phẫu thuật. Từ năm 2014 đến 2017, giá dịch vụ y tế sẽ thêm một phần trả lương, phụ cấp thu hút chuyên môn, trượt giá và các chi phí gián tiếp khác. Từ năm 2018 trở đi, giá dịch vụ y tế sẽ bao gồm tất cả các chi phí trực tiếp và gián tiếp (Chính phủ, 2012).

5.2 Đãi ngộ nhân lực y tế

Các cấu phần chi trả cho nhân lực y tế

Nhân viên y tế làm việc được trả lương hàng tháng. Lương của cán bộ y tế được tính dựa trên văn bằng và thời gian công tác. Ở Việt Nam có một hệ thống lương chung cho tất cả các ngành, trong đó quy định mức lương khởi điểm giống nhau ở những người tốt nghiệp cùng trình độ. Thời gian xét nâng lương và khoảng cách giữa các bậc lương là giống nhau.

Ngoài lương, cán bộ y tế còn được hưởng những khoản phụ cấp tùy theo ngành và khu vực làm việc. Các khoản phụ cấp này do Chính phủ quy định. Thường bao gồm: phụ cấp độc hại, phụ cấp cho người làm việc phơi nhiễm với HIV/AIDS, phụ cấp ngành, phụ cấp khu vực, phụ cấp thu hút... (Chính

phủ, 2011b). Ngoài ra, nhân lực y tế được hưởng phụ cấp trực và một số phụ cấp khác như phẫu thuật, thủ thuật. Không có dữ liệu chi tiết về các cấu phần thu nhập của nhân viên y tế.

Chi trả dựa trên hoạt động chuyên môn

Trong khu vực công, không có cơ chế chi trả dựa theo năng lực chuyên môn.

Khác biệt trong chi trả cho nhân lực y tế ở khu vực nông thôn và vùng khó khăn

Có sự khác biệt giữa mức lương của người làm việc ở khu vực khó khăn. Sự khác biệt này nằm ở các khoản phụ cấp (Chính phủ, 2009). Nhân viên y tế làm việc ở cơ sở công lập ở những vùng đặc biệt khó khăn về kinh tế xã hội được hưởng phụ cấp bằng 70% mức lương tháng hiện hưởng trong thời gian 5 năm (BYT, BNV và BTC, 2010). Nhìn chung không có sự khác biệt nhiều trong chi trả cho nhân viên y tế giữa thành thị và nông thôn.

5.3 Cung cấp tài chính cho đào tạo nhân lực y tế

Cơ chế phân bổ tài chính cho đào tạo

Ngân sách đào tạo từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp cho các cơ sở đào tạo công thông qua các cơ quan chủ quản. Các trường y công lập thuộc Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo hay Ủy ban Nhân dân tỉnh nhận ngân sách từ các cơ quan này. Các trường cao đẳng, trung cấp thường được cấp ngân sách từ Ủy ban Nhân dân tỉnh hoặc Sở Y tế tùy thuộc vào tổ chức ở từng địa phương.

Đối với các dự án hỗ trợ đào tạo, ngân sách được chuyển trực tiếp từ Ban quản lý dự án đến các cơ sở đào tạo.

Học bổng cho giáo dục

Sinh viên học trong các trường công lập đều phải đóng học phí. Tuy nhiên, nói chung học phí này khá thấp (Đồng bằng Sông Hồng). Sinh viên là người dân tộc thiểu số được miễn học phí; sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được giảm học phí (BGDĐT, BTC, BLĐT BXH, 2014). Sinh viên là đối tượng cử tuyển còn được trả sinh hoạt phí (BGDĐT, BLĐT BXH, BTC, BNV, UBNDT, 2008). Ngoài ra, Chính phủ còn tạo điều kiện cho sinh viên được vay tiền ngân hàng với lãi suất

thấp để hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong thời gian đi học (Thủ tướng Chính phủ, 2007b)

Có những tổ chức và cá nhân cung cấp học bổng khuyến học nhằm động viên sinh viên có kết quả học tập tốt hoặc có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Chi phí đào tạo cho từng loại sinh viên

Hiện nay chưa có một đánh giá đầy đủ các chi phí để đào tạo nhân lực y tế theo từng lĩnh vực.

6 Quản lý nhân lực y tế

6.1 Kế hoạch và chính sách đối với nhân lực y tế

Các chính sách quốc gia về nhân lực y tế

Chính sách nhân lực y tế được định hướng trong Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2005. Nghị quyết thể hiện các chiến lược về nhân lực y tế gồm: (1) tăng cường nguồn nhân lực y tế cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu; và (2) xây dựng và thực hiện những chính sách đãi ngộ thích hợp cho nhân lực y tế (Bộ Chính trị, 2005).

Những chính sách liên quan tới lương và phụ cấp cho cán bộ ngành y tế

Chính phủ có các chính sách ưu đãi bằng lương và phụ cấp cho ngành y tế như Nghị định số 64/2009/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thu hút, trợ cấp và các ưu đãi khác đối với cán bộ, viên chức y tế, lao động hợp đồng và cán bộ, nhân viên quân y trực tiếp làm công tác chuyên môn y tế tại các cơ sở y tế của Nhà nước ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Chính phủ, 2009).. Đến năm 2011, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định số 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức, cán bộ y tế xã, phường, thị trấn (đang làm việc theo chế độ hợp đồng theo Quyết định số 58/TTg ngày 03 tháng 02 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở) trực tiếp làm chuyên môn y tế; công chức, viên chức làm công tác quản lý, phục vụ không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các chuyên khoa HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh lý, pháp

y (sau đây gọi chung là công chức, viên chức) trong các cơ sở sự nghiệp y tế công lập (Chính phủ, 2011b).

Những chính sách về đào tạo cho khu vực đặc biệt khó khăn

Đối với những vùng đặc biệt khó khăn, Chính phủ đã có Nghị định 134 quy định đào tạo nhân lực đặc biệt được gọi là cử tuyển (Chính phủ, 2006a). Đây là việc tuyển sinh không qua thi tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp để đào tạo cán bộ, công chức, viên chức cho các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các dân tộc thiểu số chưa có hoặc có rất ít cán bộ đạt trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp.

Ngoài ra, để cụ thể hóa việc đào tạo cử tuyển, Chính phủ có quyết định số 1544 ngày 14/11/2007 về đào tạo nhân lực cho vùng khó khăn. Trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2018, tổ chức đào tạo theo chế độ cử tuyển khoảng 11.760 cán bộ y tế cho vùng khó khăn, vùng núi của các tỉnh thuộc miền Bắc và miền Trung, vùng đồng bằng sông Cửu Long và vùng Tây Nguyên tại một số trường (đại học, cao đẳng, trung cấp) y, dược và kỹ thuật y tế công lập (Thủ tướng Chính phủ, 2007a).

Gần đây có những văn bản về quản lý nguồn nhân lực y tế như Luật Khám bệnh Chữa bệnh ban hành năm 2009, có hiệu lực từ ngày 1/1/2011, trong đó có quyền của bệnh nhân, quyền của người hành nghề, kỷ luật (Quốc hội, 2009a). Nghị định 87/2011/ND-CP quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề và cấp giấy phép hoạt động (Chính phủ, 2011c). Thông tư 41/2011/TT-Bộ Y tế của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động cho cơ sở y tế (BYT, 2011b). Thông tư 22/2013/TT-Bộ Y tế của Bộ Y tế hướng dẫn đào tạo liên tục (Chính phủ, 2011c). Ngoài ra Bộ Y tế đang xây dựng các chuẩn năng lực cho từng nhóm ngành Bác sĩ đa khoa, Điều dưỡng và Răng hàm mặt.

Luật Viên chức đã được Quốc hội thông qua quy định về viên chức; quyền, nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập trong đó có các cơ sở y tế công.

Xây dựng kế hoạch nhân lực y tế

Kế hoạch nhân lực y tế dài hạn được Bộ Y tế xây dựng và ban hành trong 2 văn bản: Quy hoạch phát triển nhân lực y tế giai đoạn 2012-2020 và Kế hoạch nhân lực trong hệ thống khám chữa bệnh.

Quy hoạch phát triển nhân lực y tế giai đoạn 2012-2020 được ban hành theo Quyết định số 816/QĐ-Bộ Y tế của Bộ trưởng Y tế có dự báo về nhu cầu nhân lực và phương án tổ chức, phát triển các cơ sở đào tạo trên toàn quốc (BYT, 2012c).

Kế hoạch nguồn nhân lực cho hệ thống khám chữa bệnh giai đoạn 2016-2020 được ban hành theo Quyết định số 2992/QĐ-Bộ Y tế ngày 07/17/2015 của Bộ trưởng Y tế. Kế hoạch chỉ ra các mục tiêu tăng số cán bộ y tế thông qua nhiều chương trình đào tạo; tập trung vào phát triển chuyên khoa; tăng cường năng lực quản lý bệnh viện; và xây dựng các chính sách đãi ngộ phù hợp đối với cán bộ y tế làm việc trong hệ thống khám chữa bệnh.

6.2 Xây dựng chính sách, kế hoạch và quản lý nguồn nhân lực y tế

Quá trình xây dựng và thực hiện chính sách và kế hoạch nhân lực y tế

Việc xây dựng các chính sách liên quan đến nhân lực y tế do Bộ Y tế đề xuất, Bộ Y tế phân công hoặc giao các đơn vị chức năng liên quan dự thảo các văn bản chính sách. Văn bản dự thảo này được các đơn vị liên quan góp ý. Tùy theo mức độ liên quan mà văn bản được ban hành dưới dạng thông tư của Bộ Y tế hoặc thông tư liên Bộ giữa Bộ Y tế với các Bộ ngành liên quan, Quyết định của Thủ tướng chính phủ hoặc Nghị Định của Chính phủ.

Các văn bản chính sách của Chính phủ ban hành sẽ được triển khai có hiệu lực trên toàn quốc và sẽ được thực thi ở tất cả các địa phương.

Các bên liên quan trong xây dựng kế hoạch và quản lý nguồn nhân lực y tế

Quá trình xây dựng chính sách/quy định có thể có sự tham gia của nhiều bên liên quan. Sự tham gia của các bên liên quan được thực hiện thông qua các hoạt động tư vấn kỹ thuật, hội thảo, góp ý của

chuyên gia và xin ý kiến công chúng. Theo quy định các văn bản quy phạm pháp luật khi được ban hành đều được đăng trên trang web để xin ý kiến rộng rãi công chúng.

Về đào tạo nhân lực y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm quản lý hệ thống đào tạo bằng việc ban hành các tiêu chuẩn, chính sách đối với tuyển sinh, kiểm định chất lượng giáo dục. Bộ Y tế phối hợp cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng những chính sách có liên quan đặc biệt đến đào tạo nhân lực y tế như đào tạo liên thông, các tiêu chuẩn của cơ sở đào tạo bác sĩ, dược sĩ và điều dưỡng, xây dựng các tiêu chí kiểm định giáo dục cho các chương trình bác sĩ, điều dưỡng, etc.

Bộ Nội vụ có liên quan chặt chẽ trong việc ban hành các tiêu chuẩn về tổ chức cơ sở y tế và biên chế nhân lực, xây dựng các chính sách lương và đãi ngộ cho nhân lực y tế.

Bộ Tài chính phê duyệt ngân sách và định mức chi phí cho đào tạo cũng như lương và phụ cấp cho nhân viên y tế.

Ở địa phương, các cơ quan cấp tỉnh đóng vai trò quan trọng giải quyết các chính sách nhân lực và tuyển dụng nhân lực ở địa phương. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Y tế xây dựng chỉ tiêu biên chế cho các cơ sở y tế trong tỉnh, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh áp dụng các chính sách đãi ngộ cho nhân viên y tế. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm quản lý các trường cao đẳng và trung cấp trong tỉnh và phối hợp lựa chọn sinh viên theo chế độ cử tuyển ở một số tỉnh.

Cơ cấu tổ chức thực hiện chức năng quản lý nguồn nhân lực y tế ở các cấp

Cấu trúc của hệ thống quản lý ngành y tế được tổ chức theo hệ thống hành chính của Việt Nam gồm 4 cấp: trung ương, tỉnh, huyện, xã. Bộ Y tế là cơ quan trung ương. Ở cấp địa phương có Sở Y tế thuộc cấp tỉnh, Phòng Y tế/Trung tâm Y tế thuộc cấp huyện, và ở cấp xã là trạm y tế.

Năng lực của các đơn vị chức năng của Bộ Y tế trong quản lý nhân lực y tế

Vụ Tổ chức cán bộ và Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo là hai đơn vị chính của MOH liên quan đến các chính sách về nhân lực y tế. Hai đơn vị này được biên chế từ 20-30 công chức. Công chức của hai đơn vị này thường có kinh nghiệm làm việc từ các đơn vị cơ sở hoặc từ các địa phương.

Vụ Tổ chức cán bộ chuyên nghiên cứu đề xuất các chính sách về tổ chức bộ máy và chính sách tiền lương, đãi ngộ nhân lực y tế. Vụ TCCB thường hợp tác chặt chẽ với các đơn vị liên quan của Bộ Nội vụ trong việc xây dựng các chính sách này.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, trước đây là Vụ Khoa học và Đào tạo, trước đây thường tuyển dụng nhiều công chức có kinh nghiệm giảng dạy và quản lý đào tạo. Tuy nhiên, hiện nay số cán bộ có kinh nghiệm về đào tạo nhân lực y tế đang có xu hướng giảm.

Về thẩm quyền, trước khi có Luật Giáo dục năm 1998, Bộ Y tế giám sát và theo dõi, kiểm soát các hoạt động đào tạo nhân lực y tế. Luật Giáo dục năm 1998 và các luật sửa đổi sau này đã hạn chế thẩm quyền của MOH mặc dù nhiều dự án hỗ trợ đào tạo nhân lực y tế vẫn được giao MOH quản lý. Các quy chế đào tạo chuyên khoa và BSNT chưa được sửa đổi hoàn thiện phù hợp với Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học. Để giải quyết vấn đề này, Bộ Y tế đang phối hợp với MOET với sự chủ trì của Chính phủ hoàn thiện thể chế hoá việc quản lý đào tạo nhân lực cho y tế đảm bảo chất lượng đào tạo nhân lực y tế được kiểm soát một cách hiệu quả.

Phân cấp và uỷ quyền cho địa phương về nhân lực y tế

Chính sách về nhân lực y tế chủ yếu thuộc quyền ban hành của Chính phủ và các bộ liên quan. Trên cơ sở thẩm quyền quy định bởi pháp luật, Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn các luật hoặc điều chỉnh những vấn đề xuất hiện trong đời sống xã hội. Các Bộ ban hành Thông tư hướng dẫn Luật hoặc theo phân công được quy định trong Nghị định. Các chính sách do Chính phủ và các Bộ có hiệu lực rộng trên cả nước. Trong các chính sách về nhân

lực y tế thể hiện sự phân cấp đối với các địa phương.

Các tỉnh được phân cấp trong việc quản lý nhân lực y tế. Sở Y tế được giao cấp chứng chỉ hành nghề cho nhân lực y tế làm việc trong địa bàn tỉnh (Quốc hội, 2009a). Sở Giáo dục và Đào tạo được phân cấp quản lý các chương trình đào tạo trung cấp, theo dõi và giám sát các chương trình đào tạo cao đẳng. Ủy ban Nhân dân tỉnh có thẩm quyền quyết định thành lập cơ sở đào tạo trung cấp (Chính phủ, 2010). Về ngân sách cho nhân lực, các tỉnh được chủ động bố trí ngân sách cho đào tạo, thu hút, đãi ngộ đối với địa phương. Ủy ban Nhân dân tỉnh được quyền tuyển chọn và giới thiệu sinh viên học theo chế độ cử tuyển (Chính phủ, 2006b).

Sa thải và tuyển dụng nhân viên y tế

Việc tuyển dụng và sa thải nhân viên cho các cơ sở y tế được thực hiện theo quy định của Luật Viên chức và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn. Nhu cầu tuyển dụng được các cơ sở sử dụng nhân lực đề xuất và cấp trên phê duyệt. Tuyển dụng thường do các cơ quan chủ quản thực hiện cho các đơn vị cấp dưới

Thông thường, không có sa thải viên chức nhà nước mà trong điều kiện thay đổi về hệ thống tổ chức, nhân lực có thể được điều động sang làm công việc ở nơi khác mà không mất việc làm. Cơ quan chủ quản cấp trên chịu trách nhiệm điều động và bố trí công việc cho các nhân viên của cơ quan sử dụng nhân lực y tế.

Các viên chức y tế, nếu vi phạm về chuyên môn hoặc vi phạm pháp luật có thể bị buộc thôi việc, một hình thức kỷ luật áp dụng trong các cơ quan nhà nước. Quyết định buộc thôi việc do Thủ trưởng cơ quan ký hoặc cơ quan cấp trên tùy theo chức vụ của người bị kỷ luật.

Các nhân viên y tế hợp đồng thì việc tuyển dụng hoặc sa thải thực hiện theo quy định của Bộ Luật lao động. Trong các cơ sở dịch vụ y tế tư nhân thì việc tuyển dụng và sa thải hoàn toàn thuộc quyền của người sử dụng lao động tuy nhiên phải tuân thủ theo quy định của Bộ Luật lao động.

Quy định trả lương cho nhân viên y tế

Công chức và viên chức y tế được trả lương theo quy định trong Nghị định số của Chính phủ. Theo quy định, các công chức và viên chức y tế được phân loại theo ngành nghề, trình độ đào tạo và bậc lương và ứng với mỗi ngành nghề, ngạch bậc có một hệ số lương. Lương được hưởng là được tính bằng hệ số lương đó cộng với các hệ số phụ cấp nếu có, nhân với mức lương tối thiểu được Chính phủ công bố (Chính phủ, 2004).

6.3 Quản lý chuyên môn

Quản lý nguồn nhân lực và quy trình đăng ký hành nghề

Luật Khám bệnh chữa bệnh có hiệu lực từ ngày 1/1/2011, quy định 6 loại nhân viên y tế phải có chứng chỉ hành nghề gồm: bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh, lương y, người có bài thuốc gia truyền. Quy trình và thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề được Bộ Y tế quy định. Thông thường để được cấp chứng chỉ hành nghề, nhân viên y tế phải có văn bằng chuyên môn, có đủ thời gian thực hành chuyên môn ở cơ sở y tế phù hợp với thời gian 18 tháng đối với bác sĩ và 09 tháng đối với điều dưỡng, 09 tháng đối với hộ sinh và kỹ thuật viên, 12 tháng đối với y sĩ; đối với lương y và người có bài thuốc gia truyền cần có xác nhận của hội đồng y cấp tỉnh trở lên (BYT, 2011b).

Cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề đối với cấp trung ương là Bộ Y tế, đối với các địa phương là Sở Y tế. Đối với các quân nhân làm công tác y tế chứng chỉ hành nghề do Bộ Quốc phòng cấp (Quốc hội, 2009a).

Thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề gồm văn bằng chuyên môn, chứng nhận thực hành ở cơ sở y tế phù hợp với yêu cầu, lý lịch tư pháp, và các chứng nhận đào tạo chuyên môn khác là cơ sở để xác định phạm vi hành nghề. Tất cả hồ sơ này được một Hội đồng do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế để cử xem xét.

Chứng chỉ hành nghề được cấp một lần và có giá trị vĩnh viễn khi người hành nghề không vi phạm trong quá trình hành nghề và đảm bảo đủ thời gian đào tạo liên tục để không bị thu hồi chứng chỉ hành nghề. Như đã trình bày ở trên, để duy trì chứng chỉ

hành nghề cán bộ y tế phải tham gia đào tạo liên tục ít nhất 48 giờ trong 2 năm. Không đảm bảo yêu cầu này chứng chỉ hành nghề sẽ bị thu hồi và chỉ được cấp lại khi đáp ứng những yêu cầu bổ sung để cấp lại chứng chỉ hành nghề.

6.4 Thông tin nhân lực y tế

Chức năng của Hệ thống thông tin nhân lực y tế (HRIS)

Việt Nam chưa có hệ thống thông tin về nguồn nhân lực riêng biệt, tuy nhiên những thông tin về nhân lực đều được bao gồm trong Niên giám Thống kê y tế và Niên giám Thống kê của Tổng cục Thống kê. Thông tin này được thu thập thông qua hệ thống báo cáo từ cơ sở qua các cấp địa phương và được Bộ Y tế hoặc Tổng Cục thống kê tổng hợp và phân tích.

Niên giám Thống kê được xuất bản hàng năm. Tuy nhiên, tài liệu này thường xuất bản chậm. Niên giám Thống kê do Tổng cục Thống kê phát hành thường có dữ liệu về nhân lực y tế theo các nhóm bác sĩ, y sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và hộ sinh phân bố theo tỉnh. Thông tin nhân lực y tế của Niên giám Thống kê y tế thường chi tiết hơn của Niên giám Thống kê, có phân loại về trình độ đào tạo, gồm chuyên khoa sau đại học, đại học, cao đẳng và trung cấp.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong HRIS

Ngành y tế chưa có hệ thống thu thập thông tin điện tử đưa vào hoạt động. Các báo cáo chủ yếu vẫn dựa trên văn bản giấy và được tổng hợp ở từng cấp.

Bộ Y tế đang phát triển một hệ thống dữ liệu nhân lực trong hệ thống cấp chứng chỉ hành nghề tích hợp cả trung ương và các tỉnh. Cơ sở dữ liệu này có thể giúp cơ quan quản lý theo dõi đào tạo liên tục để duy trì chứng chỉ hành nghề. Cơ sở dữ liệu này chỉ ghi chép các thông tin về những người cần chứng chỉ hành nghề mà không có các loại nhân lực y tế khác. Tuy nhiên, hiện tại cơ sở dữ liệu này còn đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Năng lực sử dụng, phân tích và diễn giải các nguồn thông tin khác về nhân lực y tế

Dữ liệu về nhân lực y tế, ngoài nguồn từ hệ thống thu thập thường quy, còn được phản ánh qua các dữ liệu điều tra và nghiên cứu. Tổng điều tra dân số

và nhà ở Việt Nam được thực hiện 10 năm một lần và điều tra giữa kỳ chọn mẫu. Trong dữ liệu tổng điều tra có phân loại ngành nghề cho từng đối tượng dân cư. Tuy nhiên, dữ liệu này không được chia nhỏ cho từng loại nhân lực y tế mà chỉ phản ánh trình độ đào tạo của các đối tượng dân cư. Điều tra y tế quốc gia không được thực hiện thường xuyên. Điều tra gần đây nhất được thực hiện từ năm 2001 và đến nay chưa tiến hành điều tra lại nên không có cơ sở so sánh dữ liệu. Điều tra nhân khẩu học và sức khỏe (DHS) cũng được tiến hành những năm trước đây tuy nhiên lần cuối cùng được tiến hành là năm 1997 và cho đến nay chưa làm lại. Số liệu của Tổng cục Thống kê cũng được xuất bản hàng năm và có các cơ sở dữ liệu về y tế song không phân loại sâu các loại nhân lực y tế. Ví dụ: số liệu chỉ phân loại bác sĩ, y tá, dược sĩ mà không có các loại nhân lực khác như hộ sinh, kỹ thuật viên. Hơn nữa, số liệu về y tá là tập hợp của nhiều loại trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp mà không được phân biệt.

Tóm lại, có nhiều dữ liệu về nhân lực y tế tuy nhiên tản mạn, thiếu tính liên tục, thiếu giá trị so sánh và không có sự phân loại chi tiết.

6.5 Yêu cầu về nhân lực y tế

Song song với nhu cầu phát triển của kinh tế xã hội và lực lượng lao động, nhu cầu về nhân lực y tế vẫn tiếp tục tăng để đáp ứng với nhu cầu tiếp cận dịch vụ của mọi người dân. Nhu cầu tăng thêm ngoài số lượng còn cần phải tăng về chất lượng, đặc biệt vùng núi, hải đảo, nơi có nhiều cư dân dân tộc thiểu số.

Như đã trình bày ở trên, Bộ Y tế đã phê duyệt quy hoạch phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2012-2020 và Kế hoạch nguồn nhân lực cho hệ thống khám, chữa bệnh giai đoạn 2016-2020. Bộ Y tế dự báo nhu cầu nguồn nhân lực cho những năm tới được trình bày trong Bảng 20.

Bảng 20. Nhu cầu nhân lực cho hệ thống khám chữa bệnh tới năm 2020

Vùng	Bác sĩ	Điều dưỡng	Dược sĩ
Đồng bằng Sông Hồng	22.947	45.392	4.589
Trung du và Miền núi phía Bắc	13.297	37.604	2.843
Bắc trung bộ và Duyên hải miền trung	21.252	48.878	4.445
Tây Nguyên	5.595	13.429	1.221
Đông Nam bộ	17.466	36.363	3.534
Đồng bằng Sông Cửu Long	18.794	43.679	4.123
Chung cả nước	99.351	225.345	20.755

Nguồn: Trích từ (BYT, 2015b)

Bảng 21 trình bày mục tiêu nhận lực đến năm 2020 cho các chuyên khoa Ung bướu, Tim mạch và Chấn thương của Bộ Y tế.

Bảng 21. Các chỉ tiêu nhân lực chuyên khoa đến năm 2020

Tuyến	Ung thư			Tim mạch			Chấn thương		
	Số cơ sở	Số giường bệnh	Số bác sĩ chuyên khoa	Số cơ sở	Số giường bệnh	Số bác sĩ chuyên khoa	Số cơ sở	Số giường bệnh	Số bác sĩ chuyên khoa
Trung ương	13	3.220	645	13	2.200	440	11	1.300	260
Tỉnh	46	6.050	1.210	63	6.300	1.260	63	4.410	882
Tổng số	59	9.270	1.855	76	8.500	1.700	74	5.710	1.142

Nguồn: Trích từ (BYT, 2015b)

7. Kết luận

Việt Nam là quốc gia đang phát triển có tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối cao trong thập niên qua. Việt Nam cũng đang trong giai đoạn chuyển dịch từ kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhân lực y tế Việt Nam cũng đang trong giai đoạn chuyển dịch phản ánh qua sự thay đổi về chính sách của Nhà nước đối với đào tạo và sử dụng nhân lực y tế.

Nguồn cung nhân lực Việt Nam có trên 400.000 nhân viên làm việc trong hệ thống y tế công với nữ chiếm đa số. Tuy nhiên nam giới chiếm tỷ lệ cao hơn trong các nhóm trình độ cao như bác sĩ và bác sĩ chuyên khoa. Ngược lại, nữ chiếm tỷ lệ cao trong các nhóm đào tạo thấp hơn và nhạy cảm giới trong cung cấp dịch vụ như điều dưỡng và hộ sinh. Mật độ bác sĩ của Việt Nam tăng khá nhanh trong thập niên qua, đạt 7,61/1 vạn dân trong năm 2013. Tỷ lệ điều dưỡng/BS tăng lên đáng kể phản ánh sự chuyển dịch cơ cấu nhân lực theo sự thay đổi từ khám và can thiệp y khoa là chính sang chăm sóc và hỗ trợ người bệnh.

Phân bố nguồn nhân lực Ngoài cơ cấu phân bố theo giới như đã trình bày ở trên, nhân lực y tế Việt nam có cấu trúc trẻ với nhóm tuổi dưới 35 chiếm một nửa nhân lực tại các cơ sở cung cấp dịch vụ. Phân bố nhân lực y tế không đều giữa các vùng với điều kiện kinh tế xã hội khác nhau là đặc điểm chung của các nước đang phát triển. Đồng bằng sông Hồng có mật độ nhân lực y tế cao nhất. Đồng bằng Sông Cửu Long và Tây Nguyên có mật độ nhân lực thấp nhất. Mặc dù về mật độ chung không phải là thấp nhưng các khu vực miền núi, hải đảo, vùng có nhiều người dân tộc thiểu số thường có ít hơn các vùng còn lại về mật độ nhân lực trình độ cao.

Đào tạo nhân lực y tế Hệ thống đào tạo nhân lực y tế thay đổi trong những năm gần đây nên trong cơ cấu nhân lực hiện tại tương đối phức tạp và đa dạng về trình độ. Nhân lực được đào tạo mức độ cơ bản gồm đại học, cao đẳng và trung cấp có thời gian đào tạo khác nhau. Người có văn bằng ở trình độ thấp hơn như trung cấp, cao đẳng có thể học liên thông lên đại học sau một số năm làm việc. Cả nước hiện có 37 trường đại học, 40 trường cao đẳng, và 81 trường

trung cấp là các loại cơ sở chính đào tạo nhân lực y tế. Ngoài ra còn có các viện nghiên cứu đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ. Tuy nhiên, số cơ sở đào tạo bác sĩ chỉ có 18, còn lại chủ yếu đào tạo điều dưỡng, y sĩ, dược. Hệ thống đào tạo nhân lực y tế hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học; Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động giáo dục nói chung. Bộ Y tế quản lý phần đào tạo CK I, CK II, bác sĩ nội trú và đào tạo liên tục.

Các thách thức lớn nhất đối với hệ thống này là chất lượng đào tạo, trong đó những vấn đề chính được Bộ Y tế quan tâm là số sinh viên quá đông trong khi chi phí và đầu tư cho đào tạo được quy định quá thấp; các trường y và điều dưỡng thường không đủ bệnh viện thực hành so với số lượng sinh viên quá đông. Chương trình và phương pháp đào tạo vẫn mang tính truyền thống chưa hiện đại. Giảng viên còn thiếu và hạn chế về năng lực chuyên môn. Hệ thống trường tư đang phát triển mạnh trong những năm gần đây song hệ thống kiểm định chất lượng chưa hình thành và cơ chế đảm bảo chất lượng còn yếu.

Sử dụng nhân lực y tế Chỉ tiêu tuyển dụng nhân lực y tế vào các cơ sở dịch vụ y tế công do các cơ quan quản lý nhân lực của cấp bộ và chính quyền cấp tỉnh phê duyệt. Nhân lực y tế được tuyển bằng một trong hai hình thức là thi tuyển và xét quyền được quy định bởi Luật Công chức và Luật Viên chức. Luật Viên chức mới đã có hiệu lực mang lại thay đổi nhiều trong cơ chế sử dụng, cách thức tuyển dụng và hợp đồng đối với cán bộ y tế, nâng cao vai trò qua hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động trong các cơ sở y tế công.

Quản lý nguồn nhân lực Việt Nam mới áp dụng quản lý nhân lực y tế chứng chỉ hành nghề từ năm 2011. Chứng chỉ hành nghề được cấp một lần, có giá trị vĩnh viễn và có giá trị trên cả nước, do đó, nhân lực có thể di chuyển giữa các khu vực. Cấp lại chứng chỉ hành nghề chỉ áp dụng cho những người bị thu hồi do vi phạm các điều kiện hành nghề và không đảm bảo đào tạo liên tục trong 2 năm hành nghề liên tiếp. Cấp chứng chỉ hành nghề hiện nay đang bộc lộ một số khiếm khuyết và đang được Bộ Y tế

ngiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung. Hệ thống y tế tư nhân phát triển rất nhanh trong thập niên qua. Tuy nhiên, số liệu toàn quốc về nhân lực làm việc trong hệ thống này không đầy đủ.

Hệ thống thông tin về nhân lực y tế Thông tin nhân lực còn hạn chế, thiếu chính xác và không được cập nhật kịp thời, chủ yếu được tổng hợp dựa trên báo cáo hàng năm từ các tỉnh. Công nghệ thông tin chưa được sử dụng rộng rãi để thu thập và quản lý thông tin nhân lực y tế. Dữ liệu về nhân lực y tế thiếu các chỉ số cần thiết cho nhu cầu lập kế hoạch cũng như hoạch định các chính sách về sử dụng và phát triển nhân lực y tế.

Định hướng tương lai Các chính sách về nhân lực y tế tập trung vào: (1) Tạo cơ chế ưu tiên tuyển sinh đối với học sinh người dân tộc thiểu số, các vùng khó khăn và phân công làm việc tại địa phương sau khi tốt nghiệp; (2) Bổ sung cho những địa phương thiếu nhân lực bậc cao bằng nhân lực có trình độ thấp hơn như y sĩ, điều dưỡng trung cấp và có chính sách đào tạo liên thông đối với các đối tượng này; và (3) Đãi ngộ cho nhân lực y tế bằng nâng thu nhập hoặc các hình thức khen thưởng nhằm thu hút về các khu vực khó khăn chủ yếu là miền núi, hải đảo và các vùng có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống.

Tài liệu tham khảo

Anh, L.V., 2012. *Đánh giá hiện trạng đào tạo nhân lực y tế tại Việt Nam*. Hà Nội: Trường Đại học Y tế công cộng.

BDGĐT, BLĐT BXH, BTC, BNV, UBDT, 2008. *Thông tư liên tịch 13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐT BXH-BTC-BNV-UBDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP*. Hà Nội.

BGDĐT, BTC, BLĐT BXH, 2014. *Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐT BXH của Bộ Tài chính-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010*. Hà Nội.

BGDĐT, 2007. *Công văn số 1325/BGDĐT-KHTC hướng dẫn cách xác định số sinh viên, học sinh quy đổi trên 1 giảng viên, giáo viên quy đổi*. Hà Nội.

BGDĐT, 2011. *Thông tư 25/2011/TT-BGDĐT về quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng trường Đại học, Cao đẳng*. Hà Nội.

BGDĐT, 2014. *Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm 2014*. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.

BGDĐT, 2015. *Thông tư 08/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo*. Hà Nội.

BNV và BYT, 2015. *Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Y tế quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ*. Hà Nội.

BNV, 2005. *Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng*. Hà Nội.

BNV, 2012. *Thông tư số 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức*. Hà Nội.

Bộ Chính trị, 2005. *Nghị quyết của Bộ Chính trị số 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới*. Hà Nội.

BYT và BNV, 2007. *Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước*. Hà Nội.

BYT, BNV và BTC, 2010. *Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC của Bộ Tài chính-Bộ Y tế-Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm*

2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã. Hà Nội.

BYT, 2011a. *Niên giám Thống kê y tế*. Hà Nội: Nhà xuất bản Y học.

BYT, 2011b. *Thông tư số 41/2011/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh*. Hà Nội.

BYT, 2011c. *Thông tư 12/2011/TT-BYT quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức hộ sinh*. Hà Nội.

BYT, 2012a. *Niên giám Thống kê y tế*. Hà Nội: Nhà xuất bản Y học.

BYT, 2012b. *Quyết định số 3651/QĐ-BYT của Bộ trưởng Y tế về kiện toàn tổ chức Ban điều hành phát triển nguồn nhân lực y tế*. Hà Nội.

BYT, 2012c. *Quyết định số 816/QĐ-BYT phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2012-2020*. Hà Nội.

BYT, 2013a. *Niên giám Thống kê y tế*. Hà Nội: Nhà xuất bản Y học.

BYT, 2013b. *Thông tư 22/2013/TT-BYT Hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế*. Hà Nội.

BYT, 2013c. *Quyết định số 4858/QĐ-BYT về việc ban hành thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện*. Hà Nội.

BYT, 2015a. *Báo cáo tổng kết công tác y tế năm 2014, một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2015, giai đoạn 2016-2020*. Báo cáo tại hội nghị trực tuyến ngày 21/01/2015. Hà Nội.

BYT, 2015b. *Quyết định số 2992/QĐ-BYT ngày 17/07/2015 của Bộ Y tế về phê duyệt kế hoạch phát triển nhân lực trong hệ thống khám bệnh chữa bệnh giai đoạn 2015 – 2020*. Hà Nội.

Chính phủ, 2003. *Nghị định số 104/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số*. Hà Nội.

Chính phủ, 2004. *Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang*. Hà Nội.

Chính phủ, 2006a. *Nghị định số 134/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân*. Hà Nội.

Chính phủ, 2006b. *Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập*. Hà Nội.

Chính phủ, 2009. *Nghị định số 64/2009/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y*

tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Hà Nội.

Chính phủ, 2010. *Nghị định số 115/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục*. Hà Nội.

Chính phủ, 2011a. *Nghị định số 63/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế*. Hà Nội.

Chính phủ, 2011b. *Nghị định số 56/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập*. Hà Nội.

Chính phủ, 2011c. *Nghị định số 87/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh*. Hà Nội.

Chính phủ, 2012. *Nghị định số 85/2012/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập*. Hà Nội.

Chính phủ, 2015. *Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021*. Hà Nội.

Cục KHCNĐT, 2013. *Số liệu tổng hợp về đào tạo nhân lực của các trường năm 2013*. Hà Nội: Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo.

Cường, L.Q., 2011a. *Thực trạng nhu cầu và sử dụng bác sỹ, cử nhân điều dưỡng sau tốt nghiệp*. Hà Nội: Viện Chiến lược và Chính sách y tế.

Cường, L.Q., 2011b. *Đánh giá 9 tháng triển khai thực hiện đề án 1816 nhằm đề xuất các giải pháp hoàn thiện*. Hà Nội: Viện Chiến lược và Chính sách y tế.

IndexMundi, 2015. *IndexMundi*. [Online] Available at: HYPERLINK "<http://www.indexmundi.com/vietnam/>" <http://www.indexmundi.com/vietnam/> [Accessed 12 October 2015].

Quốc hội, 1998. *Luật Giáo dục*. Hà Nội.

Quốc hội, 2005. *Luật Giáo dục*. Hà Nội.

Quốc hội, 2009a. *Luật Khám bệnh, chữa bệnh*. Hà Nội.

Quốc hội, 2009b. *Luật sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục*. Hà Nội.

Quốc hội, 2012. *Luật Giáo dục đại học*. Hà Nội.

Quốc hội, 2014. *Luật Giáo dục nghề nghiệp*. Hà Nội.

Quốc hội, 2015. *Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật*. Hà Nội.

TCTK, 2009. *Tổng điều tra dân số và nhà ở 2009*. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê Tổng cục Thống kê.

TCTK, 2011. *Viet Nam Population and Housing Census 2009: Age-Sex Structure and Marital Status of the Population in Viet Nam*. Hà Nội: Tổng cục Thống kê.

TCTK, 2013. *Dân số và lao động*. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê.

TCTK, 2014a. *Niên giám Thống kê Việt Nam*. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê.

TCTK, 2014b. *Niên giám Thống kê Việt Nam 2013*. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê.

TCTK, 2014c. *Y tế Việt Nam qua tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012*. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê Tổng cục Thống kê.

Thủ tướng Chính phủ, 2007a. *Quyết định số 1544/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án đào tạo nhân lực y tế cho vùng khó khăn, vùng núi của các tỉnh thuộc miền Bắc và miền Trung, vùng đồng bằng sông Cửu Long và vùng Tây Nguyên theo chế độ cử tuyển"*. Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ, 2007b. *Quyết định số 157/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên*. Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ, 2008. *Quyết định số 1505/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường đại học Việt Nam giai đoạn 2008 - 2015"*. Hà Nội.

Viện CLCSYT, 2010. *Đánh giá thực trạng dịch chuyển cán bộ y tế từ các cơ sở y tế công lập ra ngoài công lập từ nông thôn về thành thị và đề xuất giải pháp khắc phục*. Hà Nội: Viện Chiến lược và Chính sách y tế.

Viện CLCSYT, 2015. *Đánh giá đào tạo thực hành tại các trường y Việt Nam 2014*. Hà Nội: Viện Chiến lược và Chính sách y tế.

WHO, 2015. *WHO Representative Office Vietnam*. [Online] Available at: HYPERLINK "<http://www.wpro.who.int/vietnam/topics/immunization/factsheet/en/>" <http://www.wpro.who.int/vietnam/topics/immunization/factsheet/en/> [Accessed 12 October 2015].

Phụ lục

Bảng 1. Mô tả nhiệm vụ một số loại nhân lực y tế

Ngạch	Nhiệm vụ	Yêu cầu trình độ
Điều dưỡng sơ cấp	- Thực hiện: + đón tiếp người bệnh; + chăm sóc thông thường, hoặc phụ giúp kỹ thuật điều dưỡng cơ bản; + theo dõi chức năng sống và phát hiện kịp thời các diễn biến bất thường; + chuẩn bị dụng cụ, thuốc, hồ sơ bệnh án và phụ giúp bác sĩ, điều dưỡng ở ngạch cao; + bảo quản thuốc và tài sản; + đôn đốc, nhắc nhở người bệnh, người nhà người bệnh giữ gìn vệ sinh, trật tự. - Tham gia: + sơ cứu ban đầu; + xử lý tử vong; + giáo dục sức khỏe; + các chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu. - Thực hiện các quy định về y đức, các quy chế chuyên môn của ngành y tế và các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực điều dưỡng.	Tốt nghiệp sơ học điều dưỡng
Điều dưỡng trung cấp	- Thực hiện: + Tiếp đón người bệnh; + chăm sóc toàn diện cho người bệnh; + các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, phụ giúp điều dưỡng ở ngạch cao hơn thực hiện các kỹ thuật phức tạp; + theo dõi diễn biến hàng ngày của người bệnh; + sơ cứu, cấp cứu ban đầu các trường hợp bệnh nặng, tai nạn; + chăm sóc bệnh nhân tử vong; chuẩn bị các phương tiện, dụng cụ, thuốc, hồ sơ bệnh án; + bảo quản thuốc và tài sản; + giáo dục sức khỏe; + các chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu. - Tham gia: hướng dẫn thực hành kỹ thuật điều dưỡng cơ bản cho học sinh điều dưỡng và cho viên chức điều dưỡng ở ngạch thấp hơn; - Thực hiện các quy định về y đức, các quy chế chuyên môn, các quy trình kỹ thuật của ngành y tế và các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực điều dưỡng.	Tốt nghiệp trung học điều dưỡng
Điều dưỡng cao đẳng	- Thực hiện: + lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc toàn diện; + kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và một số kỹ thuật điều dưỡng phức tạp; + theo dõi, đánh giá toàn trạng để điều chỉnh kế hoạch chăm sóc; + sơ cứu, cấp cứu ban đầu các trường hợp bệnh nặng, tai nạn; + tiếp đón người bệnh; chăm sóc bệnh nhân tử vong; + lập kế hoạch và chuẩn bị các trang thiết bị dụng cụ y tế, thuốc, hồ sơ bệnh án; + vận hành, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện máy móc, trang thiết bị đề xuất phương án xử lý kịp thời; + tư vấn, giáo dục sức khỏe; + đôn đốc, nhắc nhở người bệnh, gia đình người bệnh giữ gìn trật	Tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng - Sử dụng được một ngoại ngữ trình độ A hoặc một thứ tiếng dân tộc. - Có trình độ cơ bản về tin học.

Ngạch	Nhiệm vụ	Yêu cầu trình độ
	tự, vệ sinh; các chương trình chăm sóc sức khoẻ ban đầu và vệ sinh phòng chống dịch bệnh; + Hướng dẫn thực hành kỹ thuật điều dưỡng cho điều dưỡng ở ngạch thấp hơn; + Chịu trách nhiệm cá nhân về số thuốc và tài sản phân công quản lý; - Tham gia: nghiên cứu khoa học. - Thực hiện các quy định về y đức, các quy chế chuyên môn, các quy trình kỹ thuật của ngành y tế và các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực điều dưỡng.	
Điều dưỡng	- Thực hiện: + Lập kế hoạch chăm sóc và phối hợp với bác sĩ tổ chức thực hiện kế hoạch chăm sóc; + Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và phức tạp của chuyên khoa; + Hướng dẫn kỹ thuật điều dưỡng cho sinh viên điều dưỡng và cho điều dưỡng ở ngạch thấp hơn; + chỉ đạo tuyến; - Tổ chức thực hiện: + theo dõi, giám sát điều dưỡng ở ngạch thấp hơn; + các quy trình đón tiếp người bệnh + các thủ tục chăm sóc bệnh nhân từ vong; + theo dõi, đánh giá người bệnh để điều chỉnh kế hoạch chăm sóc và báo cáo bác sĩ kịp thời xử lý các diễn biến bất thường của người bệnh; + sơ cứu, cấp cứu và chăm sóc, điều trị cho người bệnh nặng; chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, thuốc, hồ sơ bệnh án; + vận hành, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện máy móc, trang thiết bị, phát hiện hỏng hóc và đề xuất phương án xử lý; + tư vấn, giáo dục sức khoẻ và giữ gìn trật tự, vệ sinh, phòng dịch bệnh. - Tham gia nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực điều dưỡng. - Chịu trách nhiệm cá nhân về số thuốc và tài sản phân công quản lý; - Tổ chức thực hiện các quy định y đức, các quy chế chuyên môn, các quy trình kỹ thuật của ngành y tế và các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực điều dưỡng.	- Tốt nghiệp cử nhân điều dưỡng. - Ngoại ngữ trình độ A hoặc sử dụng được một thứ tiếng dân tộc. - Đạt trình độ cơ bản về tin học, sử dụng phần mềm để phân tích số liệu.
Điều dưỡng chính	- Chủ trì, tổ chức thực hiện: + lập kế hoạch chăm sóc và phối hợp với bác sĩ trong chăm sóc, phục vụ người bệnh toàn diện; + theo dõi, giám sát các điều dưỡng ở ngạch thấp hơn trong chăm sóc người bệnh toàn diện; + các quy trình đón tiếp người bệnh, chăm sóc khi người bệnh từ vong; + giao ban điều dưỡng, đi buồng để điều chỉnh kế hoạch chăm sóc người bệnh; + sơ cứu, cấp cứu những trường hợp tai nạn và chăm sóc, điều trị cho người bệnh nặng; + quản lý các dụng cụ, phương tiện, thuốc và hồ sơ bệnh án; + vận hành bảo quản, bảo dưỡng các máy móc, trang thiết bị thuộc chuyên khoa; + tư vấn, giáo dục sức khoẻ và công tác giữ gìn trật tự, vệ sinh, phòng dịch bệnh. - Thực hiện: + các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và phức tạp thuộc chuyên	- Điều dưỡng có thâm niên ở ngạch tối thiểu là 9 năm. - Tốt nghiệp thạc sĩ hoặc chuyên khoa cấp I điều dưỡng. - Ngoại ngữ trình độ B, hoặc sử dụng thành thạo một thứ tiếng dân tộc. - Sử dụng thành thạo một số phần mềm tin học ứng dụng trong theo dõi và chăm sóc người bệnh. - Có đề tài hoặc công trình nghiên cứu khoa học được Hội

Ngạch	Nhiệm vụ	Yêu cầu trình độ
	khoa. + áp dụng những kiến thức và kỹ năng mới trong thực hành điều dưỡng. - Chủ trì hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe. - Tổ chức thực hiện công tác chỉ đạo tuyến về lĩnh vực điều dưỡng, hướng dẫn kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ điều dưỡng cho điều dưỡng ở ngạch thấp hơn và tham gia đào tạo học sinh, sinh viên điều dưỡng. - Chịu trách nhiệm cá nhân về số thuốc và tài sản được phân công quản lý. - Chủ trì, tổ chức thực hiện quy định y đức, các quy chế chuyên môn, các quy trình kỹ thuật của ngành y tế và các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực điều dưỡng.	đồng khoa học cấp ngành hoặc cấp tỉnh công nhận và áp dụng có hiệu quả
Hộ sinh sơ cấp	- Tiếp đón người bệnh; - Tham gia, chuẩn bị dụng cụ khi được phân công; - Phụ giúp hoặc trực tiếp thực hiện một số kỹ thuật thông thường, - Trực tiếp đỡ đẻ thường khi không có cán bộ chuyên môn ở ngạch cao hơn tại tuyến y tế cơ sở; - Tư vấn và thực hiện các kỹ thuật thông thường CSSKSS. - Bảo quản và chịu trách nhiệm về thuốc và vật tư y tế được phân công quản lý. - Tham gia giáo dục sức khỏe, đôn đốc người bệnh thực hiện vệ sinh môi trường. - Tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe ban đầu. - Thực hiện các quy định khác của pháp luật liên quan đến lĩnh vực chuyên khoa hộ sinh.	Tốt nghiệp sơ cấp hộ sinh
Hộ sinh trung cấp	- Tiếp đón người bệnh; - Chuẩn bị các dụng cụ, thuốc, hồ sơ bệnh án; - Thực hiện thủ thuật thông thường thuộc chuyên khoa; - Tư vấn và thực hiện các kỹ thuật thông thường về CSSKSS; - Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý thai nghén, chăm sóc toàn diện theo sự phân công; - Theo dõi, ghi chép diễn biến hàng ngày của người bệnh và báo cáo bác sĩ hoặc người phụ trách; - Sử dụng, bảo quản, vệ sinh trang thiết bị được phân công; phát hiện hỏng hóc và đề xuất phương án xử lý; - Tư vấn giáo dục sức khỏe và thực hiện các chương trình CSSKBĐ thuộc chuyên khoa. - Chịu trách nhiệm cá nhân về thuốc và tài sản được phân công quản lý. - Tham gia hướng dẫn thực hành kỹ thuật hộ sinh thông thường cho học viên và viên chức hộ sinh sơ cấp. - Thực hiện các quy định khác của pháp luật liên quan đến lĩnh vực chuyên khoa hộ sinh.	- Tốt nghiệp trung cấp hộ sinh. - Biết một ngoại ngữ thông dụng ở trình độ A trong hoạt động chuyên môn. - Sử dụng thành thạo máy vi tính và các trang thiết bị, phần mềm tin học ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn.
Hộ sinh cao đẳng	- Tổ chức tiếp đón người bệnh - Tổ chức và thực hiện tư vấn giáo dục sức khỏe, vệ sinh môi trường; - Lập kế hoạch dự trù và chuẩn bị các phương tiện, dụng cụ, thuốc, hồ sơ bệnh án; - Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch chăm sóc toàn diện; - Thực hiện các kỹ thuật cơ bản, phụ giúp thực hiện một số kỹ thuật phức tạp theo phân công của bác sĩ hoặc hộ sinh phụ trách; - Theo dõi, đánh giá toàn diện người bệnh và báo cáo bác sĩ hoặc hộ sinh phụ trách;	- Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành hộ sinh. - Biết một ngoại ngữ thông dụng ở trình độ B trong hoạt động chuyên môn. - Sử dụng thành thạo máy vi tính và các trang thiết bị, phần

Ngạch	Nhiệm vụ	Yêu cầu trình độ
	- Sử dụng, bảo quản, vệ sinh phương tiện máy móc; chịu trách nhiệm về thuốc và tài sản được phân công quản lý. - Tham gia nghiên cứu khoa học; đào tạo về hộ sinh cho học viên và viên chức hộ sinh ở ngạch thấp hơn. - Thực hiện các quy định khác của pháp luật liên quan đến lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, sơ sinh và sức khỏe sinh sản.	mềm tin học ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn.
Hộ sinh	- Tổ chức tiếp đón người bệnh; - Lập kế hoạch, chuẩn bị các phương tiện, dụng cụ, thuốc, hồ sơ bệnh án; - Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch chăm sóc toàn diện; - Thực hiện các kỹ thuật phức tạp trong chuyên khoa; - Theo dõi, đánh giá toàn diện người bệnh và báo cáo bác sĩ điều trị hoặc người phụ trách; - Kiểm tra, giám sát thống kê, báo cáo các hoạt động chuyên môn và bảo quản lưu trữ các tài liệu đúng quy định; - Lập kế hoạch và tổ chức tư vấn, giáo dục sức khỏe, vệ sinh môi trường. - Quản lý, sử dụng, bảo quản trang thiết bị; chịu trách nhiệm về thuốc và tài sản được phân công quản lý. - Tổ chức và thực hiện các chương trình CSSKBD thuộc chuyên khoa. - Tham gia chỉ đạo tuyển, nghiên cứu khoa học, đào tạo về lĩnh vực CSSKBMTE, SKSS; - Thực hiện các quy định khác của pháp luật liên quan đến lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, sơ sinh và sức khỏe sinh sản.	- Tốt nghiệp đại học ngành hộ sinh. - Biết một ngoại ngữ thông dụng ở trình độ B trong hoạt động chuyên môn. - Sử dụng thành thạo máy vi tính và các trang thiết bị, phần mềm tin học ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn.
Hộ sinh chính	- Chủ trì, tổ chức xây dựng kế hoạch chăm sóc người bệnh; - Thực hiện các kỹ thuật cao và phức tạp thuộc chuyên khoa; - Tổ chức ứng dụng những kỹ thuật mới trong hoạt động chuyên ngành. - Kiểm tra việc theo dõi, đánh giá toàn diện người bệnh, phát hiện, xử trí những trường hợp nặng, những trường hợp cấp cứu và báo cáo bác sĩ điều trị hoặc người phụ trách. - Lập kế hoạch quản lý thuốc, vật tư và trang thiết bị; - Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn trong chuyên môn và thống kê, báo cáo, bảo quản, lưu trữ các tài liệu. - Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các chương trình CSSKBD thuộc chuyên khoa. - Tổ chức chỉ đạo tuyển, nghiên cứu khoa học, đào tạo về CSSKBMTE và SKSS cho học viên và hộ sinh ở ngạch thấp hơn. - Lập kế hoạch, kiểm tra, giám sát và tổ chức tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh, gia đình người bệnh và cộng đồng. - Thực hiện các quy định khác của pháp luật liên quan đến lĩnh vực y tế.	- Tốt nghiệp sau đại học chuyên ngành hộ sinh. - Có thời gian ở ngạch hộ sinh từ 9 năm trở lên. - Biết một ngoại ngữ thông dụng ở trình độ C. - Sử dụng thành thạo máy vi tính và các trang thiết bị, phần mềm tin học ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn. - Chủ trì hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học được hội đồng khoa học cấp cơ sở trở lên công nhận và áp dụng có hiệu quả.
Bác sĩ (hạng III)	- Khám bệnh, chữa bệnh: Khám, chữa bệnh; xử trí cấp cứu thông thường, chuyển đi điều trị ở tuyến trên hoặc chuyên khoa; + Tham gia hội chẩn chuyên môn; + Quản lý và cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh. - Truyền thông, giáo dục sức khỏe; + Xác định nhu cầu về giáo dục sức khỏe;	- Tốt nghiệp bác sĩ trở lên - Có trình độ ngoại ngữ (A2) trở lên hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với

Ngạch	Nhiệm vụ	Yêu cầu trình độ
	+ Thực hiện và đánh giá hoạt động tư vấn, truyền thông, giáo dục sức khỏe + Đề xuất biện pháp quản lý sức khỏe trong phạm vi được giao. - Tư vấn lựa chọn các dịch vụ y tế phù hợp; - Sử dụng được thiết bị y tế phục vụ chẩn đoán, can thiệp điều trị, cấp cứu trong phạm vi được giao; - Tham gia giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần thuộc chuyên khoa hoặc lĩnh vực liên quan; - Tham gia chỉ đạo tuyến, triển khai phòng chống dịch và bệnh xã hội; tham gia CSSKBD ở tuyến y tế cơ sở; - Đào tạo và nghiên cứu khoa học về y học; + Tham gia biên soạn tài liệu chuyên môn; xây dựng quy chế, quy trình kỹ thuật chuyên môn thuộc lĩnh vực được giao; hướng dẫn viên chức, học sinh, sinh viên chuyên ngành y; + Tham gia hoặc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.	vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; - Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản
Bác sĩ chính (hạng II)	- Khám bệnh, chữa bệnh: + Chủ trì hoặc tham gia hội chẩn chuyên môn; + Tổ chức, thực hiện khám bệnh, chữa bệnh; + Tổ chức, xử trí cấp cứu, cấp cứu thuộc chuyên khoa; + Phát hiện và báo cáo sai sót chuyên môn kỹ thuật; + Giám sát, kiểm tra, đánh giá, cải tiến chất lượng khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi chuyên môn được giao. - Giáo dục sức khỏe: + Xác định nhu cầu, lập và thực hiện, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch giáo dục sức khỏe; + Đề xuất các biện pháp quản lý sức khỏe. - Tổ chức và thực hiện tư vấn cho người bệnh lựa chọn dịch vụ y tế phù hợp; - Sử dụng được thiết bị y tế phục vụ chẩn đoán, can thiệp điều trị, cấp cứu trong phạm vi được giao; - Tổ chức giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần; - Trực tiếp hoặc tham gia chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật, triển khai phòng, chống dịch và các bệnh xã hội; - Đào tạo và nghiên cứu khoa học: + Tổ chức biên soạn tài liệu; xây dựng quy chế, quy trình kỹ thuật chuyên môn; + Đào tạo, bồi dưỡng và chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đối với viên chức chuyên môn và học viên, sinh viên khi được giao; + Chủ trì hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học.	- Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ y học trở lên; - Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 (B1) trở lên hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; - Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; - Có chứng chỉ bồi dưỡng bác sĩ chính (hạng II).
Bác sĩ cao cấp (hạng I)	- Khám bệnh, chữa bệnh: + Chủ trì tổ chức, thực hiện khám bệnh, chữa bệnh; + Chủ trì tổ chức xử trí cấp cứu, cấp cứu thuộc chuyên khoa, trường hợp do tuyến dưới chuyển đến; + Chủ trì hội chẩn chuyên môn thuộc lĩnh vực được giao; + Chủ trì giám sát, kiểm tra, đánh giá, cải tiến chất lượng khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi chuyên môn được giao; + Xây dựng hệ thống phát hiện và báo cáo sai sót chuyên môn kỹ thuật trong phạm vi chuyên môn được giao; - Giáo dục sức khỏe: + Chủ trì lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch tư vấn, truyền thông, giáo dục sức khỏe dựa vào mục tiêu và nhu cầu thực tế; + Biên soạn, chủ trì tổ chức biên soạn nội dung thông tin, truyền	- Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II hoặc tiến sĩ y học; - Có trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2) trở lên; - Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; - Có chứng chỉ bồi dưỡng bác sĩ cao cấp (hạng I).

Ngạch	Nhiệm vụ	Yêu cầu trình độ
	thông, giáo dục sức khỏe. - Chủ trì thực hiện tư vấn cho người bệnh hoặc gia đình người bệnh lựa chọn dịch vụ y tế phù hợp; - Chủ trì tổ chức giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần thuộc chuyên khoa hoặc lĩnh vực liên quan theo quy định của pháp luật; - Chủ trì tổ chức thực hiện công tác chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật, triển khai phòng chống dịch và các bệnh xã hội khi được giao; - Chịu trách nhiệm quản lý và hướng dẫn sử dụng thiết bị y tế phục vụ chẩn đoán, can thiệp điều trị, cấp cứu trong phạm vi chuyên môn được giao; - Đào tạo và nghiên cứu khoa học về y học: + Chủ trì biên soạn tài liệu chuyên môn; xây dựng quy chế, quy trình kỹ thuật chuyên môn thuộc lĩnh vực được giao; + Tổ chức hoặc trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng và chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đối với viên chức chuyên môn thuộc phạm vi được giao và học viên, sinh viên; + Tham gia hướng dẫn, đào tạo sau đại học hoặc nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật; + Chủ trì hoặc tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học; Nghiên cứu đề xuất hoặc tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân của ngành, địa phương.	
Y sĩ (hạng IV)	- Tuyên truyền vận động, triển khai thực hiện các biện pháp chuyên môn về BVSKBMTE và KHHGĐ; - Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường tại trạm y tế và quản lý sức khỏe cộng đồng; - Xây dựng kế hoạch hoạt động và lựa chọn chương trình ưu tiên về chuyên môn y tế trong phạm vi phụ trách; - Xây dựng tủ thuốc, hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn và hợp lý, quản lý các nguồn thuốc; phát triển thuốc nam, kết hợp y học dân tộc trong phòng và chữa bệnh; - Phát hiện và báo cáo bệnh dịch, ổ dịch, tác nhân gây bệnh, yếu tố nguy cơ gây dịch, bệnh đối với sức khỏe cộng đồng; - Tham gia tổ chức phòng chống dịch, bệnh, biện pháp ngăn ngừa nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng; - Quản lý các chỉ số sức khỏe, quản lý thai, quản lý bệnh nhân mãn tính tại cộng đồng theo chỉ định của bác sĩ và tổng hợp báo cáo, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác theo quy định của pháp luật; - Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn kỹ thuật cho nhân viên y tế thôn, bản, cộng tác viên y tế/dân số tại cộng đồng; - Tham mưu cho chính quyền xã và cấp có thẩm quyền trong việc quản lý, thực hiện các nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu và tổ chức thực hiện những nội dung chuyên môn thuộc chương trình trọng điểm về y tế tại địa phương.	- Tốt nghiệp y sĩ trung cấp; - Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; - Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

Nguồn: Tổng hợp từ (BNV, 2005) , CITATION Placeholder12 \l 1033 (BYT, 2011c) , và CITATION Placeholder11 \l 1033 (BNV và BYT, 2015)

